

ASD: Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Abstrakt

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są heterogennym stanem neurorozwojowym, którego obraz obejmuje utrwalone różnice w komunikacji i wzajemności społecznej oraz ograniczone, powtarzalne wzorce zachowania, zainteresowań lub przetwarzania sensorycznego. Zakres potrzeb wsparcia jest bardzo szeroki i może zmieniać się zależnie od wieku, środowiska, zdrowia, obciążenia poznawczego i dostępnych adaptacji. Współczesne klasyfikacje DSM-5-TR i ICD-11 ujmują wcześniejsze rozpoznania, takie jak autyzm dziecięcy i zespół Aspergera, w jednej kategorii spektrum, z dodatkowymi określeniami dotyczącymi języka, funkcjonowania intelektualnego i potrzeb wsparcia.

Epidemiologia zależy od definicji przypadku i sposobu identyfikacji. Metaanalizy międzynarodowe wskazują zwykle wartości poniżej 1%, natomiast aktywny nadzór CDC w 16 obszarach USA wykazał w 2022 r. 32,2 rozpoznania na 1000 dzieci ośmioletnich, czyli około 1 na 31. Wyniku tego nie należy automatycznie przenosić na inne kraje ani na całą populację. Podłoże ASD jest wieloczynnikowe i w dużej mierze genetyczne: ryzyko powstaje z łącznego wpływu licznych powszechnych wariantów oraz mniejszej grupy rzadkich wariantów o większym efekcie. Różnice wykrywane w neuroobrazowaniu mają charakter statystyczny na poziomie grup i nie stanowią biomarkera pozwalającego diagnozować pojedynczą osobę.

Raport prowadzi od historii klasyfikacji, epidemiologii, etiologii i obrazu klinicznego do diagnozy, funkcjonowania dorosłych, komunikacji, relacji, pracy, zdrowia psychicznego i adaptacji. Część praktyczna obejmuje codzienną samoopiekę i samorzeczność osoby autystycznej, psychoterapię, farmakoterapię oraz analizę mitów i błędów interpretacyjnych. Szczególny nacisk położono na rozróżnienie między cechami rdzeniowymi ASD, rzeczywistymi ograniczeniami funkcjonalnymi, barierami środowiskowymi oraz problemami współwystępującymi wymagającymi osobnego leczenia.

Historia pojęcia i klasyfikacji ASD

Zaburzenia autystyczne opisał Leo Kanner w 1943 jako „wrodzone zaburzenie kontaktu uczuciowego” u 11 dzieci. W 1944 Hans Asperger charakteryzował podobny zespół (tzw. autystyczna psychopatia). Dopiero w 1979 Lorna Wing wprowadziła pojęcie *spektrum* autyzmu, wskazując na ciągłość od ciężkich zaburzeń po łagodne postacie (całkowita częstość ~20/10 000 dzieci z różnymi deficytami społecznymi i komunikacyjnymi).

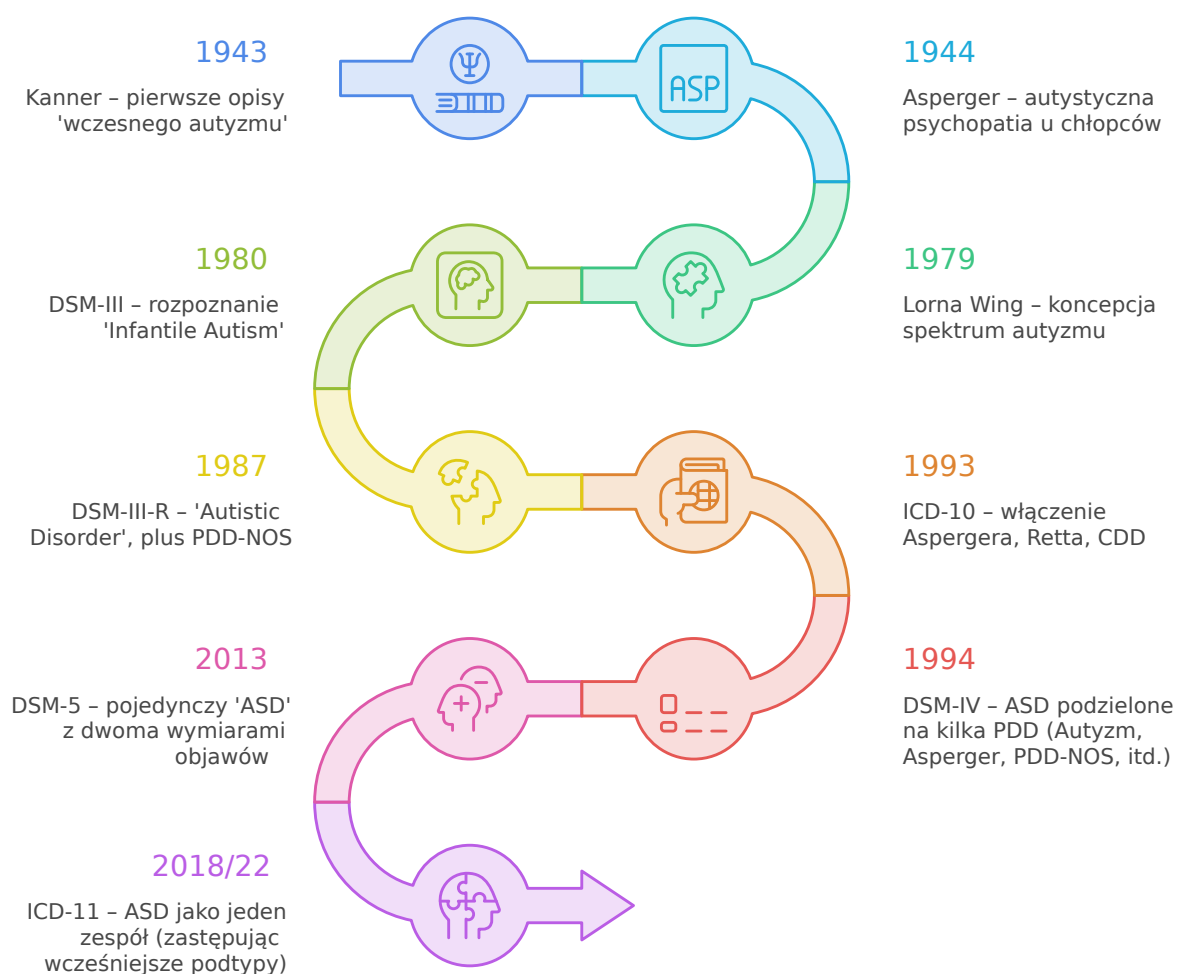
Z formalnego punktu widzenia **DSM-III (1980)** po raz pierwszy uwzględnił „wczesny autyzm dziecięcy” (Infantile Autism) jako PDD. **DSM-III-R (1987)** zmienił nazwę na *Autistic Disorder* i wprowadził nowe kryterium wielowości i opcję „nieokreślone zaburzenie rozwojowe” (PDD-NOS). **ICD-10 (1993)** zaakceptował różne podtypy: zespół Aspergera, Retta, dziecięcą regresję (CDD). **DSM-IV (1994)** wymieniał: Autyzm dziecięcy, Asperger, PDD-NOS, Rett, CDD. W **DSM-5 (2013)** zniesiono podziały na podtypy, tworząc jednolitą kategorię *ASD* z dwoma wymiarami objawów (społeczne/komunikacyjne oraz powtarzalne) i poziomami nasi-

lenia. Również **ICD-11 (opublikowane 2018, wdrożone 2022)** klasyfikuje *Autism Spectrum Disorder* bez rozdzielania Aspergera/Retta, zwracając uwagę na wspólną etiologię i spektrum objawów.

Oś czasu:

- **1943** – opis Kanner’a;
- **1944** – praca Asperger’a;
- **1979** – koncepcja spektrum Wing i Gould;
- **1980** – autyzm w DSM-III;
- **1987** – DSM-III-R i PDD-NOS;
- **1993–1994** – podtypy w ICD-10 i DSM-IV;
- **2013** – jedna kategoria ASD w DSM-5;
- **2018/2022** – klasyfikacja ASD w ICD-11.

Ewolucja zrozumienia spektrum autyzmu



Źródła: Kanner (1943); Asperger (1944); Wing i Gould (1979); American Psychiatric Association (2013, 2022); World Health Organization, ICD-11.

Epidemiologia ASD

Częstość rozpoznawania ASD wzrosła, ale obserwowany trend nie może być utożsamiany bezpośrednio ze wzrostem biologicznej zapadalności. Wpływ mają poszerzenie kryteriów, lepsza świadomość, wcześniejsza identyfikacja, zmiany w dostępie do świadczeń, zastępowanie innych rozpoznań oraz realne różnice między populacjami. Metaanaliza Salari i wsp. (2022), obejmująca 74 badania z lat 2008–2021, oszacowała globalną częstość na około 0,6% (95% CI: 0,4–1,0%). W sieci ADDM CDC w 2022 r. rozpoznanie ASD odnotowano u 32,2 na 1000 dzieci ośmioletnich, czyli u około 1 na 31, w 16 monitorowanych obszarach USA. Rozpiętość między obszarami wynosiła 9,7–53,1 na 1000, co pokazuje znaczenie lokalnych praktyk diagnostycznych i dostępności usług.

W Polsce nadal brakuje jednolitego, ogólnokrajowego systemu epidemiologicznego. Analiza rejestrów z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego z lat 2010–2014 wskazywała około 32–38 przypadków na 10 000 dzieci, czyli 3,2–3,8‰ (0,32–0,38%). Są to dane historyczne i regionalne, prawdopodobnie niedoszacowujące osoby niezdiagnozowane, dziewczęta, osoby bez niepełnosprawności intelektualnej oraz dorosłych. Porównania międzynarodowe wymagają zatem podawania wieku, roku, obszaru, źródła danych i metody identyfikacji.

Tabela 1. Porównanie wybranych danych epidemiologicznych ASD (metody: rejestry medyczno-edukacyjne vs. badania populacyjne).

Kraj/Region	Lata	Częstość	Metoda/źródło
Świat (meta)	2008–2021	0,6% (95% CI 0,4–1,0)	Metaanaliza 74 badań (rejestry, badania przesiewowe)
USA (ADDM CDC)	2022	32,2‰ (około 1:31 dzieci 8-letnich)	Aktywny nadzór w 16 obszarach; dane medyczne i edukacyjne
Anglia (GP)	2020–2021	~29–30‰ (ok. 2,9–3,0%)	Dane z kartotek lekarskich (dzieci 10–17 lat) ¹
Polska (reg.)	2010–2014	3,2–3,8‰ (0,32–0,38%)	Rejestry medyczne i orzeczenia (0–16 lat)
Źródła: Salari i wsp. (2022); CDC ADDM (2025); dane angielskie z kartotek GP; Skonieczna-Żydecka i wsp. (2017).			

¹ Dane angielskie pochodzą z kartotek podstawowej opieki zdrowotnej i dotyczą określonych grup wieku; nie są bezpośrednio porównywalne z aktywnym nadzorem CDC ani z polskimi rejestrami regionalnymi.

Etiologia – genetyka i epigenetyka

ASD ma złożoną architekturę genetyczną. Badania rodzinne i populacyjne wskazują na wysoką odziedziczalność, szacowaną w dużych analizach na około 80%, ale wartość ta opisuje różnicowanie ryzyka w populacji, a nie „procent autyzmu” u konkretnej osoby. Większość ryzyka ma charakter poligeniczny i wynika z łącznego działania wielu powszechnych wariantów o małym

efekcie. U części osób znaczenie mają rzadkie warianty liczby kopii lub warianty patogenne w genach związanych z rozwojem układu nerwowego, np. CHD8, SCN2A, ADNP lub SHANK3. Nie jest prawidłowe twierdzenie, że mutacje de novo wyjaśniają większość wszystkich sporadycznych przypadków ASD. Wydajność diagnostyczna badań genetycznych jest największa, gdy ASD współwystępuje z niepełnosprawnością intelektualną, padaczką, wadami wrodzonymi lub cechami dysmorficznymi.

Mechanizmy epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i modyfikacje histonów, mogą wpływać na ekspresję genów podczas rozwoju. Czynniki prenatalne i okołoporodowe, m.in. niektóre infekcje w ciąży, ekspozycja na określone leki, wcześniactwo lub zaawansowany wiek rodziców, są analizowane jako modyfikatory ryzyka, lecz zwykle mają niewielki efekt indywidualny i nie pozwalają wskazać pojedynczej przyczyny u danej osoby. Korelacja epidemiologiczna nie oznacza prostego związku przyczynowego. ASD nie jest skutkiem stylu wychowania ani emocjonalnej postawy rodziców.

Źródła: Bai i wsp. (2019); Grove i wsp. (2019); Satterstrom i wsp. (2020); przeglądy architektury genetycznej i diagnostyki molekularnej zaburzeń neurorozwojowych.

Neurobiologia

Badania MRI, fMRI i DTI ujawniają średnie różnice między grupami osób autystycznych i nieautystycznych w budowie oraz łączności mózgu. Analizy konsorcjum ENIGMA opisały niewielkie różnice w niektórych strukturach podkorowych i w grubości kory, zależne m.in. od wieku. Inne prace wskazują na zmienioną organizację sieci domyślnej, sieci istotności i połączeń odpowiedzialnych za integrację sensoryczną. Wyniki są jednak heterogeniczne: kierunek i wielkość efektów różnią się między próbami, a znaczne nakładanie się rozkładów uniemożliwia wykorzystanie tych cech do rutynowej diagnozy pojedynczej osoby. Podobnie modele równowagi pobudzenia i hamowania, glutaminianu, GABA lub serotoniny pozostają modelami badawczymi, a nie testami klinicznymi.

Źródła: van Rooij i wsp. (2018) oraz przeglądy neuroobrazowania i neurochemii ASD. NICE nie zaleca rutynowego stosowania neuroobrazowania ani testów biologicznych do rozpoznawania ASD u dorosłych.

Objawy społeczne, komunikacyjne, sensoryczne i poznawcze

ASD przejawia się utrwalonymi różnicami w komunikacji społecznej i wzajemności oraz ograniczonymi lub powtarzalnymi wzorcami zachowania, zainteresowań i reaktywności sensorycznej. Obraz może obejmować mniejszą spontaniczność kontaktu wzrokowego, trudność w rozpoznawaniu niejawnych intencji, dosłowne przetwarzanie języka, echolalię, silną potrzebę przewidywalności, intensywne zainteresowania i stymulację. Termin „deficyt” opisuje kryterium diagnostyczne, lecz funkcjonalne znaczenie cechy zależy od środowiska: bezpośrednia komunikacja, skupienie na szczegółach lub głęboka specjalizacja mogą być korzystne. Około jedna trzecia dzieci identyfikowanych w części systemów nadzoru ma współwystępującą niepełno-

sprawność intelektualną, ale proporcje zależą od próby i sposobu pomiaru. Zdolność mówienia i wynik IQ nie są równoważne z samodzielnością, zdolnością do wyrażania zgody ani rozumieniem sytuacji.

Źródła: DSM-5-TR; ICD-11; NICE CG142 i CG170; badania nad profilem sensorycznym, funkcjonowaniem adaptacyjnym i komunikacją społeczną.

Rozwój objawów i wpływ wieku

Cechy ASD mają początek w okresie rozwojowym, lecz mogą stać się wyraźne dopiero wtedy, gdy wymagania społeczne i organizacyjne przekraczają dostępne strategie kompensacyjne. U małych dzieci sygnałami bywają różnice w uwadze społecznej, gestach, języku, zabawie, przetwarzaniu sensorycznym lub reakcji na zmianę. W wieku szkolnym trudności mogą dotyczyć nie tylko nauki, ale także przerw, pracy grupowej, niejawnych zasad i przeciążenia. W adolescencji rośnie ryzyko lęku, depresji, odrzucenia i maskowania. U dorosłych profil pozostaje bardzo zróżnicowany: niektórzy prowadzą samodzielne życie i pracują, inni wymagają stałego wsparcia, a część funkcjonuje nierównomiernie – wysoko w jednej dziedzinie i z dużą zależnością w innej. Wyniku rozwojowego nie powinno się sprowadzać do zatrudnienia, małżeństwa lub niezależnego mieszkania; ważne są również autonomia, bezpieczeństwo, dobrostan i dostęp do komunikacji.

Źródła: badania podłużne, przeglądy funkcjonowania adaptacyjnego oraz wytyczne NICE dotyczące oceny potrzeb w całym cyklu życia.

Różnorodność obrazu ASD i diagnoza u dorosłych

Spektrum nie jest pojedynczą linią od „łagodnego” do „ciężkiego” autyzmu. Profil osoby może być nierównomierny: swobodna mowa może współistnieć z dużą trudnością w planowaniu dnia, a wysoka wiedza zawodowa z potrzebą wsparcia w sprawach urzędowych, jedzeniu lub regeneracji. Poziomy wsparcia z klasyfikacji nie są stałą miarą wartości ani kompetencji i mogą zmieniać się między obszarami oraz sytuacjami.

Późna i pomijana diagnoza

ASD bywa rozpoznawane dopiero w dorosłości, zwłaszcza u osób bez niepełnosprawności intelektualnej, z dobrze rozwiniętym językiem lub wieloletnim maskowaniem. Dziewczęta i kobiety mogą prezentować zainteresowania społecznie typowe, lecz o nietypowej intensywności, kopiować zachowania rówieśnicze i częściej ujawniać lęk, depresję, zaburzenia odżywiania albo wyczerpanie zamiast zachowań eksternalizacyjnych. Tradycyjne obrazy kliniczne i część narzędzi powstawały na próbach z przewagą chłopców, co zwiększa ryzyko błędu interpretacyjnego. Podobne bariery mogą dotyczyć osób niebinarnych, migrantów, osób z mniejszości etnicznych i osób o ograniczonym dostępie do specjalistów.

Późne rozpoznanie nie oznacza automatycznie „łagodnego autyzmu”. Może oznaczać, że osoba przez lata kompensowała trudności dużym kosztem, korzystała ze struktury zapewnianej przez rodzinę lub szkołę albo otrzymywała inne rozpoznania. Po diagnozie potrzebna jest osobna

konsultacja poświęcona jej znaczeniu, możliwościom wsparcia, zdrowiu psychicznemu, pracy, relacjom i ryzyku wypalenia.

Standard diagnozy dorosłych

Całościowa ocena powinna obejmować: cechy obecne od dzieciństwa, historię rozwoju, funkcjonowanie w domu, edukacji, pracy i relacjach, obserwację komunikacji, sensorykę, funkcje wykonawcze, stan psychiczny i somatyczny oraz ryzyko samouszkodzeń, przemocy lub wykorzystania. Informacje od rodziny są pomocne wyłącznie za zgodą osoby i nie mogą zastępować jej własnej relacji. W razie niepewności, złożonych zaburzeń współwystępujących lub rozbieżnych opinii uzasadniona jest druga konsultacja specjalistyczna.

Diagnoza różnicowa i współwystępowanie

ASD może przypominać lub współwystępować z ADHD, lękiem społecznym, OCD, PTSD, zaburzeniami nastroju, schizofrenią, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami języka i niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowe są początek rozwojowy, funkcja zachowania i zmienność w czasie. Przykładowo stimming nie jest objawem psychozy, a potrzeba rutyny nie oznacza automatycznie OCD; z kolei nowe urojenia, utrata kontaktu z rzeczywistością lub gwałtowna zmiana funkcjonowania wymagają odrębnej diagnostyki. Rozpoznanie ASD nie powinno zamykać dalszej oceny klinicznej.

Współwystępowanie (komorbidności)

Zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne współwystępują z ASD częściej niż w populacji ogólnej, ale dokładne wskaźniki zależą od wieku, sposobu diagnozy i charakteru próby. Częste są ADHD, zaburzenia lękowe, depresja, padaczka, zaburzenia snu, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia odżywiania i niektóre problemy metaboliczne. Nie należy przyjmować jednej wartości, np. 95%, jako uniwersalnej dla wszystkich osób autystycznych. Szczególne znaczenie kliniczne ma odróżnianie cechy stałej od nowej zmiany: nagłe wycofanie, agresja, utrata umiejętności lub pogorszenie snu mogą sygnalizować ból, infekcję, napad padaczkowy, depresję, traumę lub przeciążenie.

Tabela 2. Typowe współchorobowości i częstości w ASD.

Współchoroba	Częstość w ASD	Źródło danych
ADHD	~38,5% (34,0–43,2%)	Metaanaliza
Zaburzenia lękowe (dowolny rodzaj)	~20–30% dzieci	Metaanaliza
Epilepsja	~12,1% medianowo	Przegląd systematyczny
Zaburzenia snu	50–80% dzieci	Przegląd
Gastro-/metaboliczne problemy	często (np. otyłość 20–40%)	Badania kohortowe i przeglądy

Źródła: Lai i wsp. (2019) oraz metaanalizy ADHD, lęku, padaczki i zaburzeń snu w ASD; zakresy należy interpretować jako wartości populacyjne, a nie prognozę dla jednostki.

Diagnoza i ogólne zasady wsparcia

Diagnoza. Rozpoznanie ASD opiera się na całościowej ocenie klinicznej, a nie na pojedynczym kwestionariuszu, teście komputerowym, wyniku ADOS-2 ani badaniu obrazowym. U dzieci i dorosłych należy zebrać historię rozwoju, opisać funkcjonowanie w wielu środowiskach, przeprowadzić bezpośrednią obserwację oraz ocenić język, zdolności poznawcze, funkcjonowanie adaptacyjne, sensorykę i zaburzenia współwystępujące. U dorosłych przydatne mogą być dokumenty szkolne i informacje od bliskiej osoby, ale ich brak nie wyklucza diagnozy. Narzędzia takie jak ADI-R, ADOS-2, DISCO, AQ-10 lub RAADS-R wspierają proces, lecz nie zastępują osądu wyszkolonego zespołu. Diagnostyka różnicowa obejmuje m.in. ADHD, lęk społeczny, OCD, PTSD, zaburzenia nastroju, psychozę, zaburzenia osobowości, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia języka i problemy słuchu; wiele z tych stanów może jednocześnie współwystępować z ASD.

Interwencje. Nie istnieje terapia usuwająca ASD, a celem wsparcia nie powinno być wymuszanie pozornej neurotypowości. Wczesne interwencje rozwojowe, naturalistyczne i behawioralne mogą poprawiać wybrane umiejętności językowe, społeczne, zabawowe lub adaptacyjne, lecz średnie efekty są zwykle niewielkie lub umiarkowane, zależne od dziedziny i jakości badania. Nie każda osoba odpowiada tak samo, a intensywność nie powinna automatycznie zastępować indywidualizacji. Cele muszą być funkcjonalne, mierzalne i uzgodnione z osobą lub rodziną: dostęp do komunikacji, bezpieczeństwo, samodzielność, regulacja, uczestnictwo i jakość życia. Interwencje sensoryczne należy dobierać do konkretnego profilu i monitorować, ponieważ dowody nie wspierają wszystkich metod w jednakowym stopniu. Nieszkodliwego stymulingu, braku kontaktu wzrokowego lub odmiennych zainteresowań nie należy traktować jako celu eliminacji wyłącznie ze względów estetycznych.

Źródła: NICE CG142 i CG170; Sandbank i wsp. (2023, Project AIM); Pope, Light i Laubscher (2025); wytyczne podkreślające wspólne podejmowanie decyzji, ocenę funkcjonalną oraz regularny pomiar korzyści i działań niepożądanych.

Komunikacja wspomagająca i osoby o wysokich potrzebach wsparcia

Brak lub ograniczenie mowy nie jest równoznaczne z brakiem rozumienia, myślenia, preferencji ani zdolności do podejmowania decyzji. Komunikację należy oceniać wielomodalnie, uwzględniając mowę, gesty, wskazywanie, pismo, symbole, urządzenia generujące mowę, zachowanie i reakcje fizjologiczne. Zadaniem otoczenia jest zapewnienie skutecznego kanału komunikacji, a nie oczekiwanie, że osoba najpierw „udowodni” gotowość do korzystania z niego.

AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca

AAC obejmuje rozwiązania bez technologii, np. gesty, znaki i tablice literowe, oraz rozwiązania wspomagane, np. książki symboli, komunikatory i aplikacje z syntezą mowy. System powinien być dobierany przez zespół z udziałem użytkownika, dostępny stale i nauczany w naturalnych sytuacjach. Przegląd Pope, Light i Laubscher wykazał, że włączenie wspomaganej AAC do

naturalistycznych interwencji rozwojowo-behawioralnych może dodatkowo wspierać rozwój języka u dzieci z minimalną mową. Dostępne badania nie potwierdzają obawy, że prawidłowo dobrane AAC hamuje rozwój mowy; u części osób może go wspierać.

AAC nie powinno być traktowane jako nagroda, odbierane za „złe zachowanie” ani ograniczane do proszenia o podstawowe potrzeby. Osoba powinna móc odmawiać, komentować, zadawać pytania, wyrażać ból, zgodę, brak zgody, humor i własne zainteresowania. Należy odróżnić metody oparte na samodzielnym wyborze użytkownika od komunikacji facylitowanej, w której pomocnik może nieświadomie tworzyć wypowiedź; NICE nie zaleca komunikacji facylitowanej.

Ból, przeciążenie i zachowanie jako informacja

U osoby niemówiącej lub mającej trudność z interocepcją nagła agresja, autoagresja, wycofanie, odmowa jedzenia, zaburzenie snu lub utrata umiejętności mogą być sygnałem bólu, choroby, przemocy, lęku albo przeciążenia. Przed interpretacją zachowania jako „problemu autystycznego” należy ocenić możliwe przyczyny medyczne, sensoryczne, komunikacyjne i środowiskowe. Bezpieczeństwo wymaga zwracania się bezpośrednio do osoby, zapewnienia czasu na odpowiedź, respektowania odmowy i niewnioskowania o kompetencji wyłącznie na podstawie płynności mowy.

Funkcjonowanie osoby autystycznej w dorosłym życiu

Autyzm nie zanika po osiągnięciu dorosłości. Zmienia się natomiast sposób jego manifestacji. Dorosła osoba może dysponować rozbudowanymi strategiami kompensacyjnymi, wysokimi kompetencjami intelektualnymi i dużą wiedzą zawodową, a jednocześnie doświadczać istotnych trudności w zakresie regulacji sensorycznej, funkcji wykonawczych, relacji społecznych i zarządzania codziennym obciążeniem. Dlatego poziomu potrzebnego wsparcia nie można wiarygodnie określać wyłącznie na podstawie ilorazu inteligencji, wykształcenia, zdolności językowych ani pozornej samodzielności.

1. Funkcje wykonawcze i codzienna samodzielność

Funkcje wykonawcze obejmują inicjowanie działania, planowanie, organizowanie, przełączanie uwagi, hamowanie reakcji, monitorowanie postępów i pamięć roboczą. Metaanalizy wskazują, że u dorosłych z ASD trudności mogą dotyczyć szczególnie elastyczności poznawczej, planowania i generowania strategii. Nie oznacza to braku wiedzy ani zdolności logicznego myślenia. Problem często polega na przełożeniu wiedzy na działanie w zmiennym, wielozadaniowym środowisku. W praktyce osoba może:

- bardzo dobrze wykonywać skomplikowane zadanie zawodowe, ale odkładać wykonanie telefonu, opłacenie rachunku lub przygotowanie posiłku;
- rozumieć wszystkie etapy zadania, lecz nie wiedzieć, od którego rozpocząć;
- tracić ciąg działania po przerwaniu czynności;
- mieć trudność z oszacowaniem czasu i nakładu energii;
- radzić sobie dobrze przy stałym harmonogramie, lecz dezorganizować się po nieoczekiwanej zmianie;

- potrzebować zewnętrznej struktury, mimo wysokiej inteligencji.

Badania młodych dorosłych wskazują, że funkcje wykonawcze są istotnie powiązane z umiejętnościami samodzielnego życia, takimi jak zarządzanie domem, planowanie zakupów, organizowanie transportu i kontrolowanie terminów.

2. Przetwarzanie sensoryczne

U osób z ASD często występuje nadwrażliwość, niedowrażliwość albo zmienna reaktywność na dźwięk, światło, dotyk, zapach, temperaturę, ruch i sygnały płynące z własnego ciała. NICE wskazuje zmienioną wrażliwość sensoryczną jako jeden z podstawowych obszarów wpływających na funkcjonowanie dorosłych z autyzmem.

Bodziec neutralny dla większości ludzi może wymagać stałego wysiłku hamowania. Przykładowo rozmowy kilku osób, światło fluorescencyjne, klimatyzacja, zapach perfum i dźwięki urządzeń mogą być jednocześnie przetwarzane jako równorzędne, trudne do odfiltrowania informacji.

Przeciążenie może prowadzić do:

- spadku zdolności językowych i decyzyjnych;
- drażliwości lub wycofania;
- bólu, napięcia mięśniowego i zmęczenia;
- potrzeby natychmiastowego opuszczenia miejsca;
- reakcji typu meltdown, czyli utraty kontroli pod wpływem przeciążenia;
- shutdownu, czyli ograniczenia mowy, ruchu, kontaktu i inicjatywy.

Nie są to zachowania intencjonalne ani manipulacyjne. Stanowią reakcję układu nerwowego na przekroczenie dostępnej zdolności regulacyjnej.

3. Komunikacja i rozumienie społeczne

Trudności komunikacyjne u dorosłych często nie polegają na braku słownictwa, lecz na odmiennym przetwarzaniu informacji pragmatycznych. Problemem mogą być:

- niejednoznaczne polecenia;
- ironia, aluzje i znaczenia domyślne;
- oczekiwania, które nie zostały wypowiedziane;
- ocena momentu rozpoczęcia lub zakończenia rozmowy;
- rozpoznawanie intencji na podstawie mimiki i tonu;
- jednoczesne słuchanie, planowanie odpowiedzi i kontrolowanie własnego zachowania;
- rozmowy prowadzone w dużej grupie.

Część nieporozumień można wyjaśnić koncepcją „podwójnego problemu empatii”. Zakłada ona, że trudności komunikacyjne są dwustronne: osoby autystyczne mogą mieć problem z odczytywaniem osób nieautystycznych, ale osoby nieautystyczne również mogą nieprawidłowo interpretować komunikację autystyczną. Nie jest to więc wyłącznie jednostronny „deficyt społeczny”.

4. Regulacja emocjonalna i interocepcja

Interocepcja oznacza rozpoznawanie sygnałów wewnętrznych, takich jak głód, pragnienie, ból, zmęczenie, napięcie i pobudzenie emocjonalne. U części osób z ASD sygnały te są wykrywane późno, są niejednoznaczne albo pojawiają się dopiero przy dużym nasileniu. Może to powodować:

- pomijanie posiłków i odpoczynku;
- późne rozpoznawanie stresu;
- trudność w odróżnieniu lęku, złości, zmęczenia i przeciążenia;
- pozornie nagłe reakcje emocjonalne;
- trudności w wyjaśnianiu lekarzowi bólu lub objawów somatycznych.

Dodatkowym czynnikiem może być aleksytymia, czyli trudność w identyfikowaniu i opisywaniu emocji. Nie oznacza ona braku emocji. Osoba może doświadczać ich bardzo intensywnie, lecz mieć ograniczony dostęp do ich językowej reprezentacji.

5. Potrzeba przewidywalności

Rutyny i powtarzalność pełnią często funkcję regulacyjną. Ograniczają liczbę decyzji, obniżają niepewność i zmniejszają obciążenie funkcji wykonawczych. Zmiana nie jest trudna dlatego, że osoba „nie chce się dostosować”, lecz dlatego, że wymaga szybkiego zbudowania nowego modelu sytuacji. Najbardziej obciążające są zwykle:

- nagłe zmiany harmonogramu;
- brak informacji, jak długo coś potrwa;
- niejasny zakres obowiązków;
- zmiana zasad bez wyjaśnienia;
- oczekiwanie natychmiastowej odpowiedzi;
- wiele możliwych rozwiązań bez kryteriów wyboru.

6. Relacje, partnerstwo i rodzicielstwo

Dorośli z ASD mogą tworzyć bliskie, trwałe relacje i rodziny. Trudności dotyczą częściej komunikacji potrzeb, negocjowania codziennych obowiązków i interpretowania sygnałów pośrednich.

Typowe mechanizmy konfliktów obejmują:

- dosłowne rozumienie wypowiedzi;
- potrzebę samotnej regeneracji interpretowaną jako odrzucenie;
- trudność w spontanicznym okazywaniu wsparcia w oczekiwanej formie;
- odmienne potrzeby sensoryczne partnerów;
- przeciążenie liczbą obowiązków domowych;
- problemy z przełączaniem się między rolą zawodową, partnerską i rodzicielską.

Pomocne jest jawne ustalanie potrzeb, zakresów odpowiedzialności i sygnałów informujących o przeciążeniu. Oczekiwanie, że druga osoba „powinna się domyślić”, zwiększa ryzyko nieporozumień.

Maskowanie i kamuflaż społeczny

Maskowanie oznacza świadome lub częściowo automatyczne ukrywanie cech autystycznych w celu dostosowania się do norm społecznych. Szerszym pojęciem jest kamuflaż społeczny, który obejmuje zarówno maskowanie, jak i kompensowanie trudności. Kwestionariusz CAT-Q wyróżnia trzy główne komponenty:

- kompensację, czyli stosowanie wyuczonych strategii społecznych;
- maskowanie, czyli ukrywanie zachowań uznawanych za autystyczne;
- asymilację, czyli próbę wtopienia się w grupę.

Przeglądy systematyczne wskazują, że maskowanie jest związane z presją społeczną, wcześniejszym odrzuceniem, obawą przed dyskryminacją oraz potrzebą uzyskania zatrudnienia i akceptacji.

Przykłady maskowania

Maskowanie może obejmować:

- wymuszanie kontaktu wzrokowego;
- kontrolowanie gestów i mimiki;
- tłumienie stymingu, czyli ruchów samoregulacyjnych;
- przygotowywanie scenariuszy rozmów;
- kopiowanie sposobu mówienia innych osób;
- ukrywanie przeciążenia sensorycznego;
- udawanie zrozumienia wypowiedzi;
- naśladowanie zainteresowania rozmową;
- świadome analizowanie reguł społecznych;
- ukrywanie potrzeby przerwy;
- powstrzymywanie zachowań, które pomagają regulować napięcie.

Maskowanie może być skuteczne zewnętrze. Osoba jest oceniana jako komunikatywna, spokojna i dobrze funkcjonująca. Nie oznacza to jednak, że interakcja nie wymagała znacznego kosztu poznawczego i emocjonalnego.

Możliwe korzyści krótkoterminowe

Maskowanie może:

- zmniejszać ryzyko odrzucenia;
- ułatwiać przejście rozmowy kwalifikacyjnej;
- ograniczać widoczną stygmatyzację;
- umożliwiać funkcjonowanie w nieprzyjnym środowisku;
- pomagać w osiąganiu celów społecznych i zawodowych.

Z tego względu nie należy przedstawiać go wyłącznie jako zachowania patologicznego. Niekiedy jest racjonalną strategią bezpieczeństwa.

Konsekwencje długoterminowe

Systematyczny przegląd badań wykazał, że długotrwałe maskowanie wiąże się z poczuciem niedostatecznego wsparcia, wyczerpaniem, trudnościami tożsamościowymi, obniżoną samooceną i mniej autentycznymi relacjami. Najczęściej opisywane konsekwencje to:

- przewlekłe zmęczenie po kontaktach społecznych;
- depresja i lęk;
- poczucie nieautentyczności;
- trudność w określeniu własnych potrzeb;
- opóźniona diagnoza ASD;
- niedoszacowanie potrzeb przez otoczenie;
- brak dostosowań, ponieważ osoba „wygląda na dobrze funkcjonującą”;
- podatność na wykorzystywanie i przekraczanie granic;
- pogorszenie zdrowia somatycznego;
- zwiększone ryzyko wypalenia autystycznego.

Badania nie dowodzą, że każda forma kamuflażu bezpośrednio powoduje zaburzenia psychiczne. Związek może być częściowo dwukierunkowy i zależeć od stygmatyzacji, odrzucenia oraz braku wsparcia. Kierunek wyników jest jednak spójny: większe i bardziej chroniczne maskowanie jest związane z gorszym dobrostanem psychicznym.

Wypalenie autystyczne

Wypalenie autystyczne nie jest formalnym rozpoznaniem w DSM-5-TR ani ICD-11. W literaturze opisuje się je jako stan długotrwałego wyczerpania, zmniejszonej tolerancji bodźców i czasowej utraty wcześniej dostępnych umiejętności. Może objawiać się przez:

- znaczące ograniczenie zdolności do pracy;
- większą potrzebę snu i izolacji;
- trudności z mówieniem i podejmowaniem decyzji;
- nasilenie nadwrażliwości sensorycznej;
- utratę zdolności maskowania;
- częstsze shutdowny i meltdowns;
- pogorszenie samoobsługi;
- niemożność realizowania wielu zadań równocześnie.

Wypalenie autystyczne różni się od typowego wypalenia zawodowego tym, że może obejmować całe funkcjonowanie, a nie tylko pracę. Zwykle powstaje w następstwie długotrwałego niedopasowania wymagań środowiskowych do zasobów osoby, chronicznego maskowania, przeciążenia sensorycznego i niewystarczającej regeneracji.

Funkcjonowanie osoby z ASD w związku

Dorośli w spektrum autyzmu mogą odczuwać potrzebę bliskości, miłości i seksualności równie silnie jak osoby nieautystyczne. Badania nie wspierają stereotypu, że autyzm oznacza brak zainteresowania relacją. Trudności częściej dotyczą dostępu do okazji społecznych, inicjowania

znajomości, rozpoznawania niejawnych reguł randkowania oraz utrzymywania porozumienia w relacji mieszanej neuroróżnorodnie. W badaniu Strunz i wsp. (2017) większość ankietowanych dorosłych z ASD deklarowała zainteresowanie związkiem, natomiast osoby pozostające bez partnera częściej wskazywały trudności społeczne i ograniczone możliwości poznawania ludzi niż brak potrzeby więzi.

Związek nie „usuwa” trudności społecznych. Przeciwnie, długotrwała relacja wymaga częstego przełączania uwagi, negocjowania obowiązków, reagowania na subtelne sygnały emocjonalne, tolerowania zmian i wspólnej regulacji napięcia. Są to obszary, w których profil autystyczny może generować wysoki koszt poznawczy. Jednocześnie do mocnych stron często należą lojalność, szczerłość, stabilność przywiązania, koncentracja na rozwiązywaniu problemu, konsekwencja i gotowość do budowania jasnych zasad.

Najczęstsze obszary nieporozumień

- **Komunikaty pośrednie.** Partner może oczekiwać, że potrzeba zostanie rozpoznana z tonu głosu, mimiki lub kontekstu. Osoba z ASD może potraktować wypowiedź dosłownie i nie zauważyć ukrytej prośby.
- **Forma okazywania uczuć.** Przywiązanie może być wyrażane przez działania praktyczne, pamiętanie szczegółów lub rozwiązywanie problemów, podczas gdy partner oczekuje spontanicznego pocieszenia, deklaracji słownych albo określonej ekspresji mimicznej.
- **Regulacja po konflikcie.** Osoba przeciążona może potrzebować ciszy i izolacji, aby odzyskać zdolność mówienia i kontroli emocji. Partner może interpretować wycofanie jako karanie ciszą, obojętność lub porzucenie.
- **Podział obowiązków.** Zadanie ogólne, np. „dbaj bardziej o dom”, nie zawiera kryterium wykonania. Brak działania bywa odczytywany jako brak zaangażowania, choć przyczyną może być trudność inicjowania, ustalania priorytetu albo przewidywania oczekiwanej częstotliwości.
- **Intymność i sensoryka.** Dotyk, zapach, temperatura, światło i hałas mogą wpływać na gotowość do bliskości. Odmowa kontaktu w stanie przeciążenia nie musi oznaczać utraty uczuć ani pociągu.
- **Rutyna i spontaniczność.** Dla jednej osoby spontaniczna zmiana jest oznaką swobody, dla drugiej źródłem silnej niepewności i dezorganizacji.
- **Rodzicielstwo.** Hałas, brak snu i nieprzewidywalność zwiększają przeciążenie, a nierównomierny profil funkcji wykonawczych może utrudniać koordynowanie wielu drobnych obowiązków, mimo silnej więzi z dzieckiem.

Dlaczego osoba dorosła z ASD może nie otrzymywać zrozumienia i empatii

Brak zrozumienia nie wynika wyłącznie z cech osoby autystycznej. Jest efektem niedopasowania dwóch sposobów komunikacji, asymetrii społecznej i utrwalonych interpretacji zachowania. Koncepcja podwójnego problemu empatii opisuje komunikacyjne niepowodzenie jako zjawisko dwustronne: osoby autystyczne mogą mieć trudność z przewidywaniem intuicji osób nieautystycznych, ale osoby nieautystyczne również gorzej rozpoznają intencje, emocje i znaczenie zachowań autystycznych. W eksperymentach informacja była przekazywana sprawnie w gru-

pach o tym samym neurotypie, natomiast spadała w grupach mieszanych, co wskazuje na problem wzajemnego dopasowania, a nie prosty brak kompetencji po jednej stronie (Crompton i wsp., 2020).

- Zachowanie jest oceniane według norm większości. Ograniczony kontakt wzrokowy, monotonna prozodia, bezpośredniość lub niewielka ekspresja twarzy bywają automatycznie interpretowane jako chłód, arogancja, brak zainteresowania albo kłamstwo.
- Pierwsze wrażenie powstaje przed poznaniem osoby. Sasson i wsp. (2017) wykazali, że nieautystyczni obserwatorzy po bardzo krótkiej ekspozycji oceniali osoby autystyczne mniej korzystnie i deklarowali mniejszą chęć dalszej interakcji. Różnica malała, gdy oceniano wyłącznie treść wypowiedzi bez sygnałów audiowizualnych.
- Maskowanie ukrywa koszt. Partner i rówieśnicy widzą poprawne wykonanie zachowania społecznego, ale nie widzą przygotowania scenariusza, kontroli mimiki, tłumienia stimmingu ani późniejszego wyczerpania. Potrzeba odpoczynku bywa więc uznawana za przesadę.
- Wysokie kompetencje w jednej dziedzinie są błędnie uogólniane. Jeżeli osoba pracuje naukowo, mówi płynnie lub samodzielnie mieszka, otoczenie zakłada, że powinna równie łatwo rozpoznawać aluzje, zarządzać domem i regulować emocje w konflikcie.
- Związek wzmacnia oczekiwanie intuicyjności. Partner może uważać, że bliskość powinna prowadzić do automatycznego „domyślania się”. Gdy to nie następuje, różnicę poznawczą interpretuje jako brak miłości lub egoizm.
- Wcześniejsze odrzucenie zmienia zachowanie. Wielokrotna krytyka i bullying zwiększają ostrożność, lęk społeczny i wycofanie. Reakcja ochronna może następnie potwierdzać otoczeniu fałszywe przekonanie, że osoba nie chce kontaktu.
- Potrzeby partnera nieautystycznego są częściej uznawane za domyślne. Terapia par i poradniki mogą traktować normy neurotypowe jako neutralny standard, oczekując adaptacji głównie od osoby autystycznej.
- Aleksytymia i opóźniona interocepcja utrudniają szybkie wyjaśnienie stanu. Osoba może wiedzieć, że „coś jest nie tak”, lecz nazwać przeciążenie dopiero po kilku godzinach. Partner widzi reakcję bez dostępnego dla siebie wyjaśnienia.

Samotność, odrzucenie i skutki psychiczne

Przegląd systematyczny Grace i wsp. (2022) wskazuje, że dorośli autystyczni doświadczają większej samotności niż osoby nieautystyczne. Szczególne znaczenie ma samotność zbiorowa, czyli poczucie niedopasowania do społeczeństwa, a czynnikami ryzyka są m.in. brak akceptacji autyzmu, lęk, depresja i mała liczba relacji dających poczucie bezpieczeństwa. Samotność nie jest równoznaczna z preferowaniem czasu w pojedynkę: osoba może potrzebować długiej regeneracji, a jednocześnie cierpieć z powodu braku bliskiej więzi.

Historia relacji rówieśniczych ma znaczenie dla dorosłości. Metaanaliza Maïano i wsp. (2016) oszacowała, że około 44% młodych osób z ASD doświadcza wiktymizacji rówieśniczej, choć wyniki poszczególnych badań silnie się różniły. Powtarzalne odrzucenie może prowadzić do nadmiernego analizowania kontaktów, unikania inicjatywy, tolerowania niezdrowych relacji lub uznawania podstawowej akceptacji za coś, czego nie wolno utracić.

Ważne jest rozróżnienie korelacji od przyczynowości. ASD samo w sobie nie przesądza o niskiej satysfakcji ze związku. W badaniu obejmującym 95 osób autystycznych i 65 nieauty-

stycznych partnerów najważniejsze korelaty satysfakcji obejmowały postrzegane wsparcie partnera, samotność społeczną, satysfakcję seksualną i cechy osobowości. Nowsze badania podkreślają szczególnie responsywność partnera, czyli poczucie, że partner rozumie, akceptuje i adekwatnie reaguje na potrzeby (Yew i wsp., 2023; Khaw i Vernon, 2025).

Tabela 3. Wybrane dane dotyczące relacji i społecznego funkcjonowania w ASD

Wskaźnik	Wynik	Interpretacja / źródło
Prewalencja ASD w sieci ADDM, USA, dzieci 8-letnie (2022)	32,2 na 1000; około 1 na 31	CDC, 2025; dane z 16 obszarów monitorowania, nie reprezentują prostego pomiaru całej populacji świata.
Wiktyimizacja rówieśnicza dzieci i młodzieży z ASD	około 44%	Metaanaliza Maïano i wsp. (2016); wysoka heterogeniczność badań.
Próba badania długotrwałych relacji	95 osób autystycznych i 65 nieautystycznych partnerów	Yew, Hooley i Stokes (2023); satysfakcję wiązano m.in. ze wsparciem, samotnością społeczną i satysfakcją seksualną.
Badania samotności dorosłych	systematycznie wyższa niż w grupach nieautystycznych	Grace i wsp. (2022); brak jednej uniwersalnej wartości procentowej ze względu na różne narzędzia i próby.
Pierwsze wrażenia osób nieautystycznych	mniej korzystne oceny i mniejsza deklarowana chęć interakcji	Sasson i wsp. (2017); efekt pojawiał się po krótkich próbkach zachowania i był zależny od sygnałów audiowizualnych.

Warunki sprzyjające trwałemu związkowi

- jawne komunikowanie potrzeb zamiast testowania, czy partner się domyśli;
- ustalenie, co oznaczają konkretne formy wsparcia, przeprosin i okazywania uczuć;
- pisemne uzgodnienia dotyczące obowiązków, terminów i minimalnego standardu wykonania;
- protokół konfliktu: sygnał przeciążenia, uzgodniona przerwa i dokładny czas powrotu do rozmowy;
- planowanie regeneracji po pracy, spotkaniach rodzinnych i podróżach;
- uznanie potrzeb sensorycznych i zgody w obszarze dotyku oraz seksualności;
- oddzielenie intencji od efektu: dobre intencje nie unieważniają zranienia, ale nietypowy efekt nie dowodzi złej intencji;
- terapia par prowadzona przez osobę rozumiejącą autyzm u dorosłych i podwójny problem empatii;
- równomierne rozłożenie odpowiedzialności za adaptację, bez wymagania stałego maskowania tylko od partnera autystycznego.

W praktyce najbardziej użyteczne jest przejście od oceny charakteru do analizy mechanizmu. Zamiast „nie zależy ci na mnie” należy ustalić obserwowalne zdarzenie, np. „gdy po konflikcie nie odzywasz się przez kilka godzin bez informacji, odczuwam niepewność; potrzebuję krótkiej wiadomości i godziny powrotu do rozmowy”. Taki format zmniejsza niejednoznaczność, a jednocześnie zachowuje wagę emocji partnera.

Edukacja, zatrudnienie i mocne strony

Edukacja i przejście do dorosłości

Trudności edukacyjne nie zawsze wynikają z braku wiedzy. Obciążające mogą być hałas, przerwy, zmiany sal, praca grupowa, niejednoznaczne polecenia, terminy wielu zadań oraz konieczność jednoczesnego słuchania i robienia notatek. Przydatne są pisemne kryteria, materiały z wyprzedzeniem, możliwość przerwy sensorycznej, alternatywne formy odpowiedzi, mentor i plan przejścia między szkołą, studiami i pracą. Wsparcie powinno obejmować także samorozwój, finanse, mieszkanie, zdrowie i relacje, a nie kończyć się wraz z osiągnięciem pełnoletności.

Zatrudnienie i bariery systemowe

Dane zatrudnieniowe silnie zależą od definicji i kraju. Brytyjski Buckland Review wskazywał, że mniej niż 3 na 10 autystycznych osób w wieku produkcyjnym pozostawało w zatrudnieniu, a wśród absolwentów autystycznych tylko 36% pracowało w pełnym wymiarze 15 miesięcy po ukończeniu studiów. Wartości te opisują system brytyjski i nie są uniwersalnym wskaźnikiem dla Polski. Pokazują jednak dużą lukę między kompetencjami a dostępem do stabilnej pracy.

Standardowa rekrutacja często mierzy spontaniczną autoprezentację, kontakt wzrokowy, small talk i tolerancję nieprzewidywalności zamiast kompetencji zawodowych. W pracy barierami bywają niejawne zasady, częste zmiany priorytetów, open space, polityka organizacyjna i ocena „dopasowania kulturowego”. Skuteczne dostosowania obejmują praktyczne zadanie rekrutacyjne, wcześniejszą agendę, jasne obowiązki, instrukcje pisemne, przewidywalny harmonogram, mentorstwo, ciche stanowisko, elastyczność miejsca pracy i ocenę rezultatu zamiast stylu społecznego. Program zatrudnienia wspomaganego powinien wspierać zarówno pracownika, jak i pracodawcę także po rozpoczęciu pracy.

Mocne strony bez tworzenia nowego stereotypu

U części osób występują mocne strony takie jak koncentracja na szczegółach, wykrywanie wzorców, wytrwałość, pamięć faktograficzna, uczciwość, głęboka wiedza specjalistyczna lub oryginalne rozwiązywanie problemów. Nie są one jednak obowiązkowe ani automatycznie przydatne w każdym stanowisku. Narracja „autyzm jako supermoc” może unieważniać niepełnosprawność i presję wydajności, podobnie jak narracja wyłącznie deficytowa pomija zasoby. Trafne podejście polega na rozpoznaniu indywidualnego profilu i stworzeniu warunków, w których mocne strony nie są pochłaniane przez przeciążenie i konieczność maskowania.

Zdrowie psychiczne, kryzys i dostęp do opieki

Podwyższone ryzyko problemów psychicznych

Lęk, depresja, trauma, zaburzenia odżywiania, samotność i wypalenie są częste, ale nie stanowią nieuniknionej części autyzmu. Ryzyko zwiększają przewlekłe odrzucenie, bullying, bezrobocie, brak dostosowań, konflikty, dyskryminacja, maskowanie i brak możliwości komunikowania

potrzeb. Zmiana zachowania powinna prowadzić do oceny nowego problemu, a nie do automatycznego wyjaśnienia go ASD.

Samobójczość i plan bezpieczeństwa

Metaanaliza 36 badań obejmująca 48 186 osób autystycznych lub prawdopodobnie autystycznych bez współwystępującej niepełnosprawności intelektualnej wykazała łączną częstość myśli samobójczych 34,2%, planów 21,9% oraz prób i zachowań samobójczych 24,3%. Heterogeniczność była bardzo wysoka, dlatego wartości nie pozwalają przewidzieć ryzyka u konkretnej osoby ani opisać wszystkich osób z ASD, zwłaszcza z większymi potrzebami wsparcia. Mimo ograniczeń uzasadniają aktywne, bezpośrednie i dostosowane komunikacyjnie pytanie o bezpieczeństwo.

Plan kryzysowy powinien być konkretny i zapisany: indywidualne sygnały ostrzegawcze, czynniki wyzwalające, sposoby ograniczenia bodźców, preferowana forma komunikacji, osoby kontaktowe, dostęp do leków lub niebezpiecznych przedmiotów, procedura uzyskania pilnej pomocy i zasady włączania partnera lub opiekuna za zgodą osoby. Metaforyczne pytania mogą zostać źle zrozumiane; lepiej pytać wprost o myśli, zamiar, plan, środki i czas. W ostrym zagrożeniu konieczna jest natychmiastowa ocena psychiatryczna lub interwencja ratunkowa.

Bariery w ochronie zdrowia i błąd przesłonięcia diagnostycznego

Do barier należą telefoniczne umawianie wizyt, zatłoczone poczekalnie, nieprzewidywalność, szybkie tempo wywiadu, pytania ogólne, brak czasu na przetworzenie informacji oraz niewiedza personelu. Błąd przesłonięcia diagnostycznego polega na przypisaniu nowego objawu autyzmowi bez pełnej diagnostyki. Może dotyczyć bólu, padaczki, problemów stomatologicznych, depresji, PTSD, zaburzeń hormonalnych lub działań niepożądanych leków. Pomocne są paszport zdrowotny, wizyty o spokojniejszej porze, opis procedury z wyprzedzeniem, pisemne zalecenia, możliwość komunikacji tekstowej i obecność wybranej osoby wspierającej.

Starzenie się i zmiany życiowe

Raporty o ASD koncentrują się zwykle na dzieciach, przez co słabiej opisane pozostają menopauza, starzenie sensoryczne, choroby przewlekłe, żałoba, emerytura, utrata rodziców-opiekunów i zmiana miejsca zamieszkania. U starszych dorosłych nowe pogorszenie pamięci, słuchu, mobilności lub samoobsługi nie powinno być uznawane za „zwykły autyzm”. Planowanie wsparcia powinno wyprzedzać kryzys i obejmować ciągłość opieki, decyzje prawne, mieszkanie, finanse oraz sieć społeczną.

Adaptacje potrzebne w dorosłym życiu

Celem adaptacji nie powinno być sprawienie, aby osoba z ASD zachowywała się jak osoba neurotypowa. Celem jest zapewnienie porównywalnego dostępu do pracy, edukacji, relacji, opieki zdrowotnej i samodzielności. Dostosowania powinny wynikać z indywidualnego profilu funkcjonalnego, a nie jedynie z samej diagnozy.

1. Komunikacja

Najbardziej użyteczne adaptacje to:

- jasne, bezpośrednie komunikaty;
- ograniczanie ironii i niejawnych oczekiwań;
- przekazywanie ważnych informacji pisemnie;
- dzielenie złożonych zadań na etapy;
- jednoznaczne określanie terminów i kryteriów wykonania;
- uprzedzanie o zmianach;
- umożliwienie dłuższego czasu na odpowiedź;
- dopuszczenie komunikacji tekstowej zamiast telefonu;
- sprawdzanie zrozumienia bez tonu oceniającego.

Zamiast polecenia „zrób to możliwie szybko” należy podać konkretny termin i rezultat, np. „prześlij wersję roboczą do środy do godziny 12.00, w formacie PDF”.

2. Środowisko sensoryczne

Możliwe dostosowania obejmują:

- ciche stanowisko pracy;
- ograniczenie światła fluorescencyjnego;
- możliwość używania słuchawek;
- pracę zdalną lub hybrydową;
- dostęp do spokojnego pomieszczenia;
- możliwość regulacji temperatury i oświetlenia;
- unikanie obowiązkowej pracy w otwartej przestrzeni;
- ograniczenie zapachów i niepotrzebnych bodźców;
- możliwość wykonywania nieszkodliwych zachowań samoregulacyjnych.

Adaptacje sensoryczne często są tanie, a mogą istotnie zwiększać wydajność i zmniejszać absencję.

3. Organizacja pracy

Pomocne są:

- przewidywalny harmonogram;
- wyraźny zakres obowiązków;
- jeden wskazany przełożony lub mentor;
- ograniczenie częstych zmian priorytetów;
- pisemne podsumowania spotkań;
- możliwość pracy w blokach bez przerw;
- ograniczenie wielozadaniowości;
- regularne, konkretne informacje zwrotne;
- ocena efektów pracy zamiast stylu społecznego;
- możliwość uczestniczenia w spotkaniach zdalnie;
- wcześniejsze przekazywanie agendy.

NICE rekomenduje programy zatrudnienia wspomaganego i koordynację usług zdrowotnych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych i zawodowych.

4. Rekrutacja

Standardowa rozmowa kwalifikacyjna może mierzyć spontaniczną autoprezentację, kontakt wzrokowy i płynność rozmowy, zamiast rzeczywistych kompetencji. Lepsze procedury to:

- wcześniejsze przekazanie pytań lub zakresu rozmowy;
- praktyczne zadanie zawodowe;
- jednoznaczne pytania;
- niewymaganie kontaktu wzrokowego;
- rezygnacja z oceny „dopasowania kulturowego”;
- możliwość odpowiedzi pisemnej;
- ograniczenie panelu rekrutacyjnego;
- umożliwienie obecności osoby wspierającej.

5. Samodzielne życie

Wsparcie może obejmować:

- planery i harmonogramy wizualne;
- automatyczne płatności;
- listy kontrolne;
- przygotowywanie posiłków według stałego planu;
- dzielenie obowiązków domowych na niewielkie zadania;
- przypomnienia dotyczące leków, posiłków i higieny;
- pomoc asystenta w wybranych czynnościach;
- wsparcie w zarządzaniu finansami;
- trening umiejętności prowadzony w realnym środowisku.

Dorośła osoba może potrzebować wsparcia punktowego, np. tylko przy sprawach urzędowych, organizacji leczenia lub planowaniu tygodnia. Nie oznacza to całkowitej niesamodzielności.

6. Ochrona zdrowia

W placówkach medycznych potrzebne mogą być:

- możliwość umawiania wizyty internetowo;
- pierwszy lub ostatni termin wizyty;
- ograniczenie czasu w poczekalni;
- opis przebiegu badania przed jego wykonaniem;
- jasne pytania zamiast ogólnych;
- uwzględnienie nietypowego opisu bólu;
- możliwość obecności osoby wspierającej;
- pisemne zalecenia po wizycie;
- niewyjaśnianie każdego objawu przez sam autyzm.

NICE podkreśla potrzebę uwzględniania środowiska fizycznego, sposobu komunikacji oraz współwystępujących zaburzeń psychicznych i somatycznych.

7. Relacje i życie społeczne

Adaptacje obejmują:

- zgodę na komunikację bezpośrednią;
- planowanie spotkań z wyprzedzeniem;
- prawo do wcześniejszego wyjścia;
- niewymuszanie kontaktu wzrokowego;
- akceptowanie okresowej potrzeby samotności;
- ustalanie zasad konfliktu i sygnałów przeciążenia;
- niewymaganie udziału we wszystkich wydarzeniach grupowych;
- budowanie relacji wokół wspólnych zainteresowań;
- terapię par dostosowaną do specyfiki autyzmu.

8. Regeneracja i ograniczanie maskowania

Całkowite „odmaskowanie” nie zawsze jest bezpieczne lub możliwe. Racjonalnym celem jest ograniczenie maskowania tam, gdzie jego koszt przewyższa korzyści. Pomocne może być:

- identyfikowanie sytuacji generujących największy koszt;
- planowanie czasu regeneracji po spotkaniach;
- dopuszczenie stimmingu;
- ograniczenie wymuszonego kontaktu wzrokowego;
- budowanie bezpiecznych relacji;
- uczenie rozpoznawania własnych granic;
- terapia neuroafirmatywna;
- kontakt ze społecznością osób autystycznych;
- rozróżnianie adaptacyjnej strategii od samounieważniania.

Zasada nadrzędna

Osoba z ASD nie powinna otrzymywać adaptacji dopiero wtedy, gdy nastąpi załamanie funkcjonowania. Dostosowania powinny mieć charakter profilaktyczny. Pozorna zdolność do wykonania zadania nie oznacza, że koszt jego wykonania jest akceptowalny. Najtrafniejszym pytaniem nie jest:

- „Czy ta osoba potrafi to zrobić?”

lecz:

- „Jakim kosztem wykonuje to zadanie, jak długo może utrzymać taki poziom wysiłku i jakie warunki pozwolą jej funkcjonować stabilnie?”

Autyzm staje się niepełnosprawnością szczególnie wtedy, gdy środowisko wymaga ciągłego tłumienia naturalnych mechanizmów regulacyjnych, ignoruje potrzeby sensoryczne i opiera komunikację na niejawnych zasadach. Odpowiednie adaptacje nie są przywilejem. Są mechanizmem wyrównania warunków uczestnictwa.

Jak dbać o siebie każdego dnia: samoopieka i samorzeczność osoby autystycznej

Ten rozdział jest skierowany bezpośrednio do osób autystycznych. Nie zastępuje indywidualnej diagnozy ani leczenia. Jego celem jest pokazanie, jak organizować codzienne życie w sposób, który ogranicza przeciążenie, zwiększa samodzielność i pomaga chronić poczucie własnej wartości w sytuacjach, gdy otoczenie nie rozumie autystycznego sposobu komunikacji lub funkcjonowania. Skuteczna samoopieka nie polega na stałym zmuszaniu się do zachowania neurotypowego. Polega na rozpoznawaniu własnych potrzeb, świadomym używaniu podpór, podejmowaniu odpowiedzialności za własne działania i jednoczesnym odmawianiu przyjęcia odpowiedzialności za cudze stereotypy, przemoc lub brak dobrej woli.

Punkt wyjścia: trudność nie jest wadą charakteru

Autystyczna cecha, ograniczenie funkcjonalne i bariera środowiskowa nie są tym samym. Potrzeba rutyny, bezpośredni sposób mówienia, ograniczony kontakt wzrokowy lub stymulacja mogą być neutralnymi cechami, które nie wymagają naprawiania. Trudność z rozpoczęciem zadania, rozpoznaniem głodu, regulacją napięcia albo organizacją obowiązków może realnie ograniczać funkcjonowanie i wymagać strategii kompensacyjnych. Z kolei hałaśliwe biuro, niejawne zasady rodzinne lub przełożony przekazujący sprzeczne polecenia są barierami środowiskowymi. W praktyce te trzy poziomy często się nakładają, ale ich rozróżnienie zmniejsza nieuzasadnione poczucie winy i ułatwia wybór właściwego rozwiązania.

Przydatne pytanie nie brzmi wyłącznie: „Co jest ze mną nie tak?”, lecz: „Co dokładnie jest trudne, w jakich warunkach, jakim kosztem i co może zmniejszyć ten koszt?”. Takie podejście funkcjonalne nie oznacza zaprzeczania słabościom. Pozwala je opisać bez moralnej oceny i zamienić ogólną samokrytykę na konkretny problem do rozwiązania.

Codzienny bilans energii, bodźców i wymagań

Wydolność osoby autystycznej może istotnie zmieniać się między dniami. Zależy nie tylko od motywacji, lecz także od jakości snu, bólu, napięcia, liczby zmian, intensywności kontaktów społecznych, bodźców sensorycznych, konieczności maskowania oraz obciążenia funkcji wykonawczych. Dzień pozornie „lekki” może być kosztowny, jeżeli wymaga wielu rozmów, przełączania uwagi i tolerowania hałasu. Warto dlatego planować nie tylko czas, ale również energię i czas regeneracji.

- Rano oceń w prostej skali 0–5 poziom energii, napięcia i wrażliwości sensorycznej. Skala nie musi być idealna; ma ułatwiać zauważanie trendu.
- Wybierz jedno zadanie niezbędne, najwyżej dwa ważne oraz zadania opcjonalne. W gorszym dniu ograniczenie planu jest strategią regulacyjną, a nie porażką.
- Po wydarzeniu społecznym, podróży, wizycie lekarskiej lub intensywnym spotkaniu pozostaw bufor bez nowych obowiązków.
- Nie czekaj z przerwą do momentu utraty mowy, paniki, meltdownu lub shutdownu. Wczesne sygnały przeciążenia są wskazaniem do zmniejszenia wymagań.
- Sprawdzaj podstawy fizjologiczne: jedzenie, nawodnienie, sen, ból, temperatura, ruch

i przyjęcie leków. Interocepcja może sygnalizować potrzeby z opóźnieniem.

Słabości i dysfunkcje: podejście funkcjonalne zamiast samokrytyki

Samoakceptacja nie oznacza uznania, że każda trudność jest niezmienna ani że nie trzeba pracować nad zachowaniem krzywdzącym innych. Oznacza oddzielenie wartości osoby od sprawności wykonania konkretnego zadania. Można jednocześnie uznać: „Mam realny problem z planowaniem”, „potrzebuję pomocy” oraz „nie jestem przez to gorszym człowiekiem”. Badania nad samowspółczuciem u dorosłych autystycznych wskazują na związki z lepszą regulacją emocji i mniejszym nasileniem lęku lub depresji, ale dowody dotyczące programów treningowych są nadal wstępne. U części osób ćwiczenia samowspółczucia mogą początkowo wywoływać dyskomfort, zwłaszcza po doświadczeniach przemocy, wstydu lub chronicznej krytyki; wtedy powinny być wprowadzane stopniowo, czasem z pomocą terapeuty.

- Opisuj zachowanie konkretnie: zamiast „jestem leniwy” – „nie rozpocząłem zadania, ponieważ było niejasne i wymagało sześciu decyzji”.
- Szukaj funkcji i warunków: co uruchomiło problem, co go podtrzymało, co pomogło choć częściowo?
- Dobieraj kompensację do trudności: alarm, lista kroków, automatyczna płatność, gotowy szablon wiadomości, pomoc drugiej osoby albo zmiana środowiska.
- Oceniaj strategię po wyniku i koszcie, a nie po tym, czy wygląda „normalnie”. Słuchawki, komunikacja tekstowa i stałe menu mogą być racjonalnymi narzędziami.
- Po błędzie przejdź od oceny siebie do naprawy skutku: nazwij problem, przeproś za konkretny skutek, popraw rozwiązanie i ustal zabezpieczenie na przyszłość.

Podpory dla funkcji wykonawczych

Pamięć robocza, inicjowanie działania i przełączanie uwagi nie powinny być traktowane jako test siły woli. Zewnętrzna struktura odciąża układ poznawczy. Metaanaliza interwencji samokierowania wskazuje, że samomonitorowanie, analiza zadania, instrukcje wizualne i technologie przypominające mogą wspierać wybrane umiejętności życia codziennego, choć baza badań jest niewielka, oparta głównie na schematach pojedynczych przypadków i nie obejmuje wszystkich obszarów samodzielności.

- Rozbij zadanie do pierwszej czynności fizycznej, np. „otwórz dokument”, a nie „napisz raport”.
- Używaj list zamkniętych: każda pozycja powinna mieć kryterium ukończenia, a nie ogólne hasło.
- Łącz czynność z istniejącym punktem dnia, np. leki po pierwszym posiłku, rachunki w stały dzień miesiąca.
- Ogranicz liczbę decyzji: przygotuj zestawy ubrań, powtarzalne śniadania, szablony zakupów i wiadomości.
- Zapisuj ustalenia natychmiast. Nie zakładaj, że ważna informacja zostanie utrzymana w pamięci tylko dlatego, że została zrozumiana.
- Przy zadaniach obciążających używaj obecności wspierającej osoby, wspólnego rozpoczęcia

albo krótkich sesji pracy, jeżeli zwiększa to wykonanie bez odbierania autonomii.

Jak komunikować swoje potrzeby

Otoczenie często oczekuje, że potrzeba będzie widoczna w mimice, tonie głosu lub spontanicznym zachowaniu. U osoby autystycznej sygnały te mogą być odmienne albo pojawiać się z opóźnieniem. Dlatego warto komunikować potrzeby wcześniej, możliwie konkretnie i w formie, która pozostawia ślad. Nie jest to gwarancja zrozumienia, ale zmniejsza przestrzeń dla domysłów.

- Nazwij obserwowalny problem: „W pokoju jednocześnie rozmawiają trzy osoby i przestaję rozumieć wypowiedzi”.
- Opisz skutek funkcjonalny: „Potrzebuję wtedy więcej czasu i mogę odpowiedzieć zbyt ostro albo przestać mówić”.
- Podaj jedno wykonalne rozwiązanie: „Porozmawiajmy pojedynczo” albo „wyślij mi to również w wiadomości”.
- Ustal sposób sprawdzenia: „Napiszę podsumowanie ustaleń; proszę potwierdzić, czy rozumiemy je tak samo”.
- Gdy mówienie jest utrudnione, użyj tekstu, przygotowanej karty, aplikacji AAC lub wcześniej uzgodnionego sygnału przerwy. Możliwość mówienia w spokojnym stanie nie wyklucza potrzeby komunikacji alternatywnej podczas przeciążenia.

Przykładowy komunikat: „Chcę rozwiązać tę sprawę, ale obecnie jestem przeciążony i przestaję prawidłowo przetwarzać mowę. Potrzebuję 30 minut przerwy. O 18.30 wrócę do rozmowy i odpowiem także pisemnie”. Taki komunikat łączy granicę z informacją, kiedy i jak nastąpi powrót do tematu.

Gdy inni rozumieją wypowiedź inaczej, niż zamierzono

Nieporozumienie nie dowodzi automatycznie, że wypowiedź była zła ani że druga osoba działała w złej wierze. Komunikacja jest procesem dwustronnym, a różnice neurotypów zwiększają ryzyko odmiennych interpretacji tonu, mimiki, dosłowności, pauzy i intencji. Jednocześnie intencja nie usuwa skutku: można nie chcieć zranić i mimo to wywołać ból. Najbardziej użyteczne jest oddzielenie czterech elementów: tego, co powiedziano, zamierzonego znaczenia, interpretacji odbiorcy i rzeczywistego skutku.

Procedura naprawy nieporozumienia

- Zatrzymaj eskalację. Gdy napięcie uniemożliwia przetwarzanie informacji, ustal przerwę i konkretny czas powrotu.
- Poproś o wskazanie konkretnej wypowiedzi lub zachowania, a nie ogólnej oceny typu „zawsze jesteś arogancki”.
- Powtórz własną intencję bez unieważniania skutku: „Chciałem przekazać informację, ale rozumiem, że forma zabrzmiała jak krytyka”.
- Zapytaj o preferowaną formę: „Czy wolisz, żebym najpierw powiedział, jaki jest cel uwagi, czy żebym wysłał ją pisemnie?”.
- Zapisz nowe ustalenie jako regułę operacyjną, np. „uwagi o błędach przekazujemy prywatnie i z przykładem”.

- Jeżeli druga osoba odmawia konkretów, zmienia znaczenie ustaleń lub wykorzystuje diagnozę do podważania każdej wypowiedzi, problem może wykraczać poza zwykłe nieporozumienie.

Dom, związek i rodzina

W bliskich relacjach szczególnie szkodliwe jest założenie, że miłość powinna umożliwiać domyślanie się potrzeb. Osoba autystyczna może potrzebować bardziej jawnych reguł, ale partner lub rodzina również mają prawo do własnych potrzeb i informacji o skutkach zachowania. Dobrą praktyką jest oddzielenie rozmowy o emocjach od negocjacji rozwiązania. Najpierw należy ustalić, co każda osoba przeżywa i czego potrzebuje, a dopiero potem rozdzielić zadania, terminy i odpowiedzialność.

- Ustalcie sygnał przeciążenia, zasady przerwy i maksymalny czas powrotu do rozmowy. Przerwa bez powrotu może być odbierana jako porzucenie konfliktu.
- Podział obowiązków opierajcie na dostępnej energii, zdolnościach i czasie, a nie na stereotypach płci lub założeniu, że osoba sprawna zawodowo musi być równie sprawna w domu.
- Nie omawiajcie trudnych spraw podczas przeciążenia sensorycznego, przed snem ani bezpośrednio po pracy, jeżeli wtedy regularnie spada zdolność komunikacji.
- Proście o zachowanie, nie o zmianę osobowości: „napisz, gdy się spóźnisz” jest wykonalne; „bądź bardziej normalny i spontaniczny” nie określa działania.
- Autyzm może wyjaśniać mechanizm, lecz nie usprawiedliwia przemocy, kontroli, gróźb, łamania zgody ani chronicznego ignorowania jasno wyrażonych granic - po żadnej ze stron.

Praca i edukacja

W pracy i edukacji negatywna ocena często dotyczy stylu społecznego, a nie jakości zadania. Bezpośredniość może zostać uznana za brak szacunku, pytanie o kryteria za opór, a ograniczona mimika za brak zaangażowania. Nie da się całkowicie kontrolować cudzych pierwszych wrażeń, ale można zmniejszać ryzyko przez wcześniejsze ustalenie kanału komunikacji, pisemne podsumowania i pytania operacyjne.

- Po spotkaniu wysyłaj krótkie podsumowanie: zadanie, termin, osoba odpowiedzialna, kryterium ukończenia.
- Gdy polecenie jest niejasne, przedstaw dwie interpretacje zamiast pytać ogólnie: „Czy priorytetem jest szybkość, czy pełna dokumentacja?”.
- Proś o informację zwrotną opartą na przykładzie i oczekiwanym zachowaniu, a nie na cechach osobowości.
- Dokumentuj istotne ustalenia i powtarzające się incydenty. Ułatwia to odróżnienie pojedynczego nieporozumienia od systematycznej dyskryminacji lub mobbingu.
- Dostosowanie ma usuwać barierę, nie obniżać wymagań merytorycznych: może to być agenda wcześniej, ciche stanowisko, komunikacja tekstowa, jasne terminy albo ograniczenie nagłych zmian.

Ujawnianie diagnozy, granice i proszenie o pomoc

Ujawnienie diagnozy jest decyzją kontekstową. Może ułatwić uzyskanie dostosowań i wyjaśnić potrzeby, ale może również narazić na stereotypizację. Nie zawsze trzeba podawać rozpoznanie,

aby opisać barierę i rozwiązanie. Można powiedzieć: „Najlepiej wykonuję zadanie, gdy otrzymuję kryteria pisemnie” albo „w tym oświeceniu szybko rozwija się ból i spada koncentracja”. W relacjach prywatnych zakres ujawnienia zależy od zaufania i bezpieczeństwa.

- Przed ujawnieniem określ cel: informacja, konkretne dostosowanie, wyjaśnienie zachowania czy prośba o udział w leczeniu.
- Przekazuj tyle informacji, ile jest potrzebne do osiągnięcia celu. Diagnoza nie odbiera prawa do prywatności.
- Pomoc nie musi być całkowita. Możesz potrzebować wsparcia tylko przy telefonach, urzędach, planowaniu tygodnia albo rozmowach konfliktowych.
- Granica powinna wskazywać twoje działanie: „Jeżeli rozmowa przechodzi w krzyk, przerwę ją i wrócę do niej później”, a nie próbować sterować cudzymi emocjami.
- Rozróżniaj brak umiejętności od braku dobrej woli. Osoba może początkowo nie rozumieć potrzeby, ale powinna być gotowa słuchać, pytać i respektować uzgodnione rozwiązania.

Regeneracja i zapobieganie wypaleniu autystycznemu

Regeneracja nie jest nagrodą przyznawaną dopiero po ukończeniu wszystkich obowiązków. Jest warunkiem podtrzymania funkcjonowania. Długotrwałe przekraczanie możliwości, chroniczne maskowanie i brak kontroli nad środowiskiem mogą prowadzić do narastającego wyczerpania, utraty wcześniej dostępnych umiejętności i wzrostu wrażliwości sensorycznej. Literatura dotycząca wypalenia autystycznego opiera się w dużej mierze na badaniach jakościowych i nie tworzy jeszcze formalnych kryteriów diagnostycznych, ale opisane doświadczenia są klinicznie istotne.

- Zapisz własne wczesne sygnały: więcej błędów, trudność w mówieniu, ból, bezsenność, płaczliwość, wycofanie, drażliwość, utrata tolerancji dźwięku.
- Ustal plan redukcji obciążenia na trzy poziomy: lekki, znaczny i kryzysowy. Nie podejmuj wszystkich decyzji dopiero w stanie przeciążenia.
- Ogranicz maskowanie tam, gdzie jest bezpieczne: nie wymuszaj kontaktu wzrokowego, pozwól sobie na nieszkodliwy stimming, wybieraj komunikację tekstową i odzież tolerowaną sensorycznie.
- Chroń aktywności regeneracyjne, które rzeczywiście regulują: samotność, powtarzalne zainteresowanie, ruch, muzykę, kontakt z naturą, sen lub przewidywalną rutynę.
- Po okresie załamania wracaj do aktywności stopniowo. Krótkotrwała poprawa nie oznacza pełnego odtworzenia zasobów.

Codzienny plan minimum

Plan minimum służy utrzymaniu bezpieczeństwa i podstawowej regulacji w dni o małej dostępności zasobów. Nie musi być realizowany samodzielnie. Można użyć przypomnień, checklisty, gotowych produktów, pomocy bliskiej osoby albo asystenta. Zakres powinien być dostosowany do zdrowia, niepełnosprawności i sytuacji życiowej.

Obszar	Pytanie kontrolne	Minimalne działanie
Ciało	Czy jadłem, piłem, przyjąłem leki i rozpoznałem ból?	Woda, prosty posiłek, leki zgodnie z zaleceniem; w razie nowych objawów kontakt z pomocą medyczną.
Sensoryka	Czy środowisko przekracza moją	Zmniejszenie światła lub hałasu, słuchawki, wygodna odzież,

Obszar	Pytanie kontrolne	Minimalne działanie
	tolerancję?	krótka zmiana miejsca.
Plan	Co jest dziś naprawdę konieczne?	Jedno zadanie niezbędne zapisane jako pierwszy konkretny krok.
Komunikacja	Czy ktoś czeka na ważną informację?	Krótką wiadomość: stan, potrzeba, termin odpowiedzi lub prośba o przełożenie.
Regeneracja	Czy mam zaplanowany czas bez wymagań?	Co najmniej jeden chroniony blok regulacji bez rozmów i nowych decyzji.
Bezpieczeństwo	Czy narasta kryzys, samouszkodzenie lub brak kontroli?	Uruchomienie wcześniej przygotowanego planu kryzysowego i kontakt z wybraną osobą lub służbą.
Refleksja	Co dziś pomogło, a co zwiększyło koszt?	Jedno zdanie w notatniku; dane służą dostosowaniu kolejnego dnia, nie ocenianiu siebie.

Kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc

Samoopieka ma granice. Nowa lub szybko narastająca zmiana funkcjonowania nie powinna być automatycznie przypisywana autyzmowi. Konsultacji medycznej lub psychologicznej wymagają między innymi utrzymująca się bezsenność, znacząca utrata masy ciała, ból, omdlenia, napady, nagła utrata umiejętności, objawy psychozy, nasilona depresja, przemoc, uzależnienie, samouszkodzenia oraz myśli samobójcze. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia potrzebna jest natychmiastowa pomoc ratunkowa. Dobrze przygotowany plan kryzysowy powinien zawierać wczesne sygnały, czynniki wyzwalające, preferowany sposób komunikacji, metody obniżania bodźców, dane osób wspierających, leki i informacje medyczne.

Warto szukać specjalisty, który rozumie różnicę między terapią problemu współwystępującego a próbą eliminowania nieszkodliwych cech autystycznych. Profesjonalne wsparcie może obejmować psychoterapię dostosowaną do ASD, terapię zajęciową, logopedię lub AAC, konsultację psychiatryczną, fizjoterapię, poradnictwo zawodowe, wsparcie pary albo pomoc społeczną. Korzystanie z pomocy jest strategią zwiększania autonomii, a nie dowodem jej braku.

Zasada końcowa

Nie każda reakcja otoczenia jest trafną informacją o tobie. Część krytyki wskazuje realny skutek, który warto naprawić; część wynika z różnicy komunikacyjnej; część jest stereotypem albo próbą kontroli. Codzienna samoopieka polega na uczeniu się rozróżniania tych sytuacji. Odpowiedzialność oznacza uwzględnianie wpływu własnego zachowania, ale nie wymaga uznawania każdej cudzej interpretacji za prawdę. Można rozwijać umiejętności i jednocześnie chronić swoją tożsamość, potrzebę regulacji, granice oraz prawo do komunikacji w dostępnej formie.

Podstawa naukowa: zalecenia NICE CG142 dotyczące autonomii, samodzielnego zarządzania, komunikacji, adaptacji środowiska i planowania kryzysowego; badania nad podwójnym problemem empatii i komunikacją między neurotypami; Raymaker i wsp. (2020) w zakresie wypalenia autystycznego; Cai i wsp. (2023, 2024) w zakresie samowspółczucia i regulacji emocjonalnej; Aydin, Sulu i Ari-Arat (2025) w zakresie interwencji samokierowania i umiejętności życia codziennego. Zalecenia należy indywidualizować, ponieważ większość badań nie obejmuje pełnej różnorodności wieku, zdolności językowych, niepełnosprawności intelektualnej i potrzeb wsparcia.

Psychoterapia u osób z ASD

Miejsce psychoterapii i cele leczenia

Psychoterapia nie leczy autyzmu jako cechy neurorozwojowej i nie powinna być ukierunkowana na wymuszanie zachowań neurotypowych. Jej celem jest zmniejszenie cierpienia, leczenie zaburzeń współwystępujących, rozwijanie strategii regulacji emocjonalnej i sensorycznej, poprawa komunikacji oraz zwiększenie autonomii i jakości życia. Najlepiej udokumentowane wskazania dotyczą lęku, depresji, stresu, trudności w regulacji emocji, następstw traumy, problemów w relacjach oraz zachowań stanowiących zagrożenie dla osoby lub otoczenia. Dobór metody powinien wynikać z indywidualnej diagnozy funkcjonalnej, a nie z samego rozpoznania ASD.

Skuteczność psychoterapii

Najwięcej danych dotyczy terapii poznawczo-behawioralnej dostosowanej do profilu autystycznego. Metaanalizy wskazują, że dostosowana CBT może zmniejszać objawy lękowe, szczególnie u dzieci i młodzieży bez znacznej niepełnosprawności intelektualnej, które są w stanie uczestniczyć w pracy werbalnej. Wyniki dotyczące depresji, objawów obsesyjno-kompulsyjnych i dobrostanu dorosłych są bardziej niejednorodne, a liczba wysokiej jakości badań jest mniejsza. Efekt zależy nie tylko od nurtu, lecz również od stopnia dostosowania terapii, kompetencji terapeuty w zakresie autyzmu, zgodności celów z potrzebami osoby oraz ograniczenia przeciążenia sensorycznego i komunikacyjnego.

Dowody dla terapii opartych na uważności, ACT i interwencji ukierunkowanych na regulację emocjonalną są obiecujące, ale słabsze niż dla dostosowanej CBT. Terapia dialektyczno-behawioralna jest badana w odniesieniu do samouszkodzeń, zachowań samobójczych i nasilonej dysregulacji emocji u dorosłych autystycznych; wyniki wstępne uzasadniają jej rozważenie w wyspecjalizowanych ośrodkach, lecz nie pozwalają jeszcze traktować jej jako uniwersalnego standardu. Dla klasycznej psychoterapii psychodynamicznej, terapii interpersonalnej i wielu niespecyficznych form poradnictwa baza dowodowa specyficzna dla ASD pozostaje ograniczona. Nie oznacza to braku możliwej korzyści, ale wymaga ostrożnego monitorowania rezultatów.

Główne nurty i zastosowania

Podjęście	Najczęstsze cele	Stan dowodów i uwagi
Dostosowana CBT	Lęk, depresja, OCD, radzenie sobie ze stresem, elastyczność zachowania	Najlepiej zbadana; szczególnie skuteczna w leczeniu lęku. Wymaga konkretnego języka, struktury i materiałów wizualnych.
ACT	Akceptacja trudnych doświadczeń, działanie zgodne z wartościami, ograniczenie walki z niezmiennymi cechami	Wyniki obiecujące, lecz mniej badań niż dla CBT. Może być zgodna z podejściem neuroafirmatywnym.
Interwencje mindfulness	Redukcja stresu, rozpoznawanie pobudzenia, regulacja emocji	Możliwa poprawa dobrostanu i lęku; potrzebne dostosowanie ćwiczeń do interocepcji i nadwrażliwości sensorycznej.

Podjęcie	Najczęstsze cele	Stan dowodów i uwagi
DBT	Dysregulacja emocji, impulsywność, samouszkodzenia, kryzysy	Rosnąca baza dowodowa u dorosłych; wskazana ocena ryzyka i terapeuta znający ASD.
Terapia traumy, w tym dostosowana TF-CBT lub EMDR	PTSD, skutki przemocy, molestowania, przewlekłego odrzucenia	Leczy traumę, nie autyzm. Tempo i ekspozycja muszą uwzględniać sensorykę, komunikację i możliwość przeciążenia.
Terapia par i rodzinna	Komunikacja potrzeb, konflikty, podział obowiązków, intymność, rodzicielstwo	Pomocna, gdy nie patologizuje jednej strony. Powinna uwzględniać podwójny problem empatii i neurotyp obu partnerów.
Interwencje behawioralne i funkcjonalne	Zachowania trudne, samoobsługa, umiejętności adaptacyjne	Powinny być oparte na analizie funkcji zachowania i jakości życia; niedopuszczalne jest tłumienie nieszkodliwych zachowań samoregulacyjnych wyłącznie dla pozornej normalizacji.

Jak powinien przebiegać proces psychoterapii

- Etap 1 – kwalifikacja i diagnoza problemu: ocena objawów współwystępujących, ryzyka samobójczego, traumy, funkcji wykonawczych, aleksytymii, potrzeb sensorycznych, sposobu komunikacji, poziomu wsparcia oraz dotychczasowych doświadczeń terapeutycznych.
- Etap 2 – uzgodnienie celów: cele powinny być konkretne, mierzalne i ważne dla osoby, np. zmniejszenie liczby napadów paniki, poprawa snu, skuteczniejsze rozpoznawanie przeciążenia albo ograniczenie konfliktów. Celem nie powinno być samo zwiększenie kontaktu wzrokowego, tłumienie stymingu lub nauka maskowania.
- Etap 3 – dostosowanie metody: sesje powinny mieć przewidywalną strukturę, jasną agendę, prosty język, ograniczoną liczbę metafor, materiały pisemne lub wizualne, regularne przerwy oraz możliwość komunikacji tekstowej. W razie zgody można włączyć partnera, członka rodziny lub inną osobę wspierającą.
- Etap 4 – aktywna praca terapeutyczna: psychoedukacja, trening rozpoznawania stanów fizjologicznych i emocji, ćwiczenie strategii w realnych sytuacjach, eksperymenty behawioralne, stopniowana ekspozycja, planowanie regeneracji i modyfikacja środowiska.
- Etap 5 – pomiar rezultatów: regularna ocena objawów, jakości życia, kosztu maskowania, przeciążenia, funkcjonowania w relacjach oraz działań niepożądanych terapii. Brak postępu powinien prowadzić do zmiany strategii, a nie automatycznego przypisywania winy „oporowi” pacjenta.
- Etap 6 – zapobieganie nawrotom: spisany plan wczesnych sygnałów przeciążenia, strategii reagowania, osób kontaktowych i warunków środowiskowych niezbędnych do stabilnego funkcjonowania.

Zalecenia praktyczne

- Psychoterapeuta powinien posiadać wiedzę o ASD u dorosłych, maskowaniu, wypaleniu autystycznym, sensoryce, aleksytymii i podwójnym problemie empatii.
- Leczenie zaburzenia współwystępującego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla tego zaburzenia, ale z modyfikacją sposobu komunikacji i tempa pracy.

- Należy odróżniać zachowania wynikające z przeciążenia, bólu, niewyspania lub trudności komunikacyjnych od celowego sprzeciwu.
- W przypadku zachowań trudnych pierwszym krokiem jest analiza funkcjonalna i usunięcie czynników podtrzymujących, a nie kara lub automatyczna farmakoterapia.
- Terapia powinna być neuroafirmatywna: wspierać autonomię i funkcjonowanie bez narzucania obowiązku „wyglądania mniej autystycznie”.
- Przy współwystępującym ryzyku samobójczym, psychozie, manii, ciężkiej depresji, przemocy lub poważnym zaniedbaniu samoopieki konieczna jest pilna konsultacja psychiatryczna i plan bezpieczeństwa.

NICE zaleca, aby interwencje poznawcze i behawioralne u dorosłych były bardziej konkretne i ustrukturyzowane, wykorzystywały informacje pisemne i wizualne, explicite wyjaśniały reguły społeczne, ograniczały metafory i niejednoznaczność oraz uwzględniały przerwy i zainteresowania osoby. U dzieci i młodzieży z lękiem zalecane jest rozważenie indywidualnej lub grupowej CBT dostosowanej do potrzeb autystycznych. Dla zachowań trudnych pierwszeństwo mają interwencje psychospołeczne oparte na analizie funkcjonalnej (NICE CG142; NICE CG170).

Farmakoterapia u osób z ASD

Zakres i ograniczenia farmakoterapii

Nie istnieje lek, który leczyłby ASD jako całość lub usuwał jego rdzeniowe cechy. Farmakoterapia jest stosowana przede wszystkim do leczenia zaburzeń współwystępujących i ściśle określonych objawów, takich jak ciężka drażliwość i agresja, ADHD, depresja, zaburzenia lękowe, bezsenność, padaczka albo objawy psychotyczne. NICE nie zaleca rutynowego stosowania leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, oksytocyny ani leków prokognitywnych w celu leczenia rdzeniowych cech autyzmu.

Skuteczność i główne grupy leków

Problem kliniczny	Najczęstsze grupy	Skuteczność i główne ryzyka
Ciężka drażliwość, agresja, samouszkodzenia	Atypowe leki przeciwpsychotyczne, przede wszystkim risperidon lub aripiprazol	Najlepsze dowody dotyczą krótkoterminowego zmniejszenia drażliwości u dzieci i młodzieży. Ryzyka: przyrost masy ciała, zaburzenia metaboliczne, senność, objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia lub akatyzja. Nie są lekami na społeczne i komunikacyjne cechy ASD.
ADHD	Psychostymulanty, atomoksetyna, agoniści alfa-2, np. guanfacyna	Mogą zmniejszać nieuwagę, nadpobudliwość i impulsywność, lecz średnia odpowiedź bywa słabsza, a działania niepożądane częstsze niż w ADHD bez ASD. Dobór według standardowych wytycznych ADHD i profilu pacjenta.

Problem kliniczny	Najczęstsze grupy	Skuteczność i główne ryzyka
Depresja i zaburzenia lękowe	Najczęściej SSRI lub inne leki zgodne z wytycznymi dla danego zaburzenia	Dowody specyficzne dla ASD są ograniczone, szczególnie u dzieci. Możliwe pobudzenie, zaburzenia snu, dolegliwości żołądkowo-jelitowe i nasilenie myśli samobójczych na początku leczenia u części młodych osób. Wymagane powolne zwiększanie i ścisłe monitorowanie.
Zaburzenia snu	Melatonina po wdrożeniu interwencji behawioralnej i higieny snu	Może skracać czas zasypiania i wydłużać sen, zwłaszcza u dzieci. Najpierw należy wykluczyć ból, bezdech, refluks, padaczkę, wpływ innych leków i nieprawidłowy harmonogram.
Padaczka	Leki przeciwpadaczkowe dobrane do typu napadów	Leczą padaczkę współwystępującą, nie ASD. Konieczna ocena interakcji, wpływu na zachowanie i funkcje poznawcze.
Psychoza, choroba afektywna dwubiegunowa, ciężkie zaburzenia nastroju	Leki zgodne z wytycznymi dla rozpoznanego zaburzenia	Wymagają pełnej diagnostyki różnicowej. Nietypowa komunikacja, stimming lub wycofanie nie powinny być automatycznie uznawane za psychozę.

Leki przeciwpsychotyczne

Risperidon i aripiprazol mają najlepiej udokumentowane działanie w ograniczaniu ciężkiej drażliwości, agresji i samouszkodzeń u części dzieci i młodzieży autystycznej. Korzyść dotyczy zachowania docelowego, a nie rdzeniowych cech ASD. U dorosłych baza dowodowa jest znacznie słabsza. Leki te należy rozważać dopiero po ocenie bólu, chorób somatycznych, snu, lęku, przeciążenia sensorycznego, komunikacji oraz czynników środowiskowych. Gdy interwencje psychospołeczne są nieskuteczne lub niemożliwe z powodu ciężkości zachowania, leczenie powinien rozpocząć specjalista, z jednoznacznym wskaźnikiem skuteczności. NICE zaleca ocenę efektu i działań niepożądanych po 3–4 tygodniach oraz odstawienie, jeżeli do 6. tygodnia nie wystąpi klinicznie istotna poprawa.

Leczenie ADHD

Współwystępujące ADHD może istotnie pogarszać naukę, pracę, bezpieczeństwo i samodzielność. Stosuje się leki zgodne z wytycznymi ADHD: psychostymulanty, atomoksetynę lub agoniści receptorów alfa-2. U osób z ASD częściej obserwuje się drażliwość, spadek apetytu, zaburzenia snu, labilność emocjonalną albo nasilenie stereotypii, dlatego zalecane jest rozpoczęcie od małych dawek, wolniejsze zwiększanie oraz ocena funkcjonowania w więcej niż jednym środowisku. Sam fakt występowania ASD nie jest przeciwwskazaniem do leczenia ADHD.

Leczenie lęku i depresji

Leki przeciwdepresyjne nie powinny być stosowane rutynowo w celu ograniczenia powtarzalnych zachowań lub poprawy komunikacji społecznej. Mogą być natomiast uzasadnione w rozpoznanej depresji, zaburzeniu lękowym, OCD lub PTSD, zgodnie z wytycznymi dla tych zaburzeń. Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy pogorszenie nie wynika przede wszystkim z wypalenia autystycznego, przewlekłego przeciążenia, przemocy, izolacji, problemów somatycznych lub niedostosowanego środowiska. U osób mających trudność w opisywaniu stanów

wewnętrznych warto monitorować także zmiany zachowania, snu, apetytu, aktywności i tolerancji bodźców.

Leczenie zaburzeń snu

Podstawą jest diagnoza przyczyny i plan behawioralny: regularne pory, ograniczenie światła i pobudzających aktywności, dostosowanie sensoryczne sypialni oraz leczenie bólu, refluksu, zapaść, bezdechu lub lęku. Melatoninę można rozważyć, gdy problemy utrzymują się mimo prawidłowo prowadzonego planu snu i wyraźnie zaburzą funkcjonowanie osoby lub rodziny. U dzieci decyzję powinien podejmować specjalista z doświadczeniem w ASD lub medycynie snu. Należy kontrolować efekt, porę podawania, senność dzienną i potrzebę dalszego stosowania.

Proces bezpiecznego leczenia farmakologicznego

- Zdefiniowanie problemu docelowego: przed włączeniem leku należy opisać konkretny objaw, jego częstotliwość, nasilenie, kontekst i wpływ na jakość życia.
- Diagnostyka różnicowa: ocena bólu, infekcji, padaczki, zaburzeń snu, problemów żołądkowo-jelitowych, działań innych leków, przeciążenia sensorycznego, przemocy i zmian środowiskowych.
- Ustalenie punktu odniesienia: masa ciała, ciśnienie i tętno, sen, apetyt, zachowanie oraz – zależnie od leku – badania metaboliczne, EKG lub inne parametry.
- Zasada „start low, go slow”: zwykle celowe jest rozpoczynanie od małej dawki i wolniejsze zwiększanie, ponieważ reakcje mogą być atypowe, a zgłaszanie działań niepożądanych utrudnione.
- Jedna zmiana naraz: ogranicza ryzyko błędnego przypisania poprawy lub pogorszenia konkretnemu lekowi.
- Pomiar efektu: stosowanie prostych skal, dzienniczka snu lub zachowania i opinii osoby, rodziny, szkoły lub miejsca pracy – zależnie od sytuacji.
- Regularny przegląd wskazania: każda kontrola powinna odpowiadać na pytania, czy lek nadal jest potrzebny, czy korzyść przewyższa ryzyko i czy możliwe jest zmniejszenie dawki lub odstawienie.
- Plan odstawienia: części leków nie należy odstawiać nagle. Zmniejszanie dawki powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i z monitorowaniem nawrotu objawów.

Monitorowanie działań niepożądanych

- W przypadku leków przeciwpsychotycznych: masa ciała i BMI, obwód pasa, ciśnienie, glikemia lub HbA1c, lipidogram, senność, objawy ruchowe, akatyzja, prolaktyna i funkcjonowanie seksualne – zależnie od preparatu i objawów.

- W przypadku leków na ADHD: ciśnienie, tętno, masa ciała, apetyt, sen, drażliwość, lęk i ewentualne tiki.
- W przypadku leków przeciwdepresyjnych: pobudzenie, bezsenność, objawy manii, pogorszenie lęku, myśli samobójcze, zaburzenia seksualne i dolegliwości somatyczne.
- W przypadku melatoniny: czas zasypiania, łączny czas snu, senność poranna, regularność rytmu dobowego i zasadność kontynuacji.
- Osoba autystyczna może nie zgłaszać działań niepożądanych w typowy sposób. Nagła zmiana zachowania, większa nadwrażliwość, wycofanie lub utrata umiejętności powinny skłonić do ponownej oceny leczenia.

Zalecenia i interwencje niewskazane

- Nie stosować leków wyłącznie po to, aby osoba była bardziej uległa, mniej widocznie autystyczna lub łatwiejsza w opiece.
- Nie rozpoczynać leczenia ciężkich zachowań bez sprawdzenia bólu, problemów somatycznych, komunikacyjnych i środowiskowych.
- Nie traktować poprawy po sedacji jako pełnowartościowego efektu terapeutycznego; oceniana powinna być jakość życia i funkcjonowanie.
- Nie stosować rutynowo leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, oksytocyny, sekretyny ani preparatów prokognitywnych do leczenia rdzeniowych cech ASD.
- Unikać polipragmazji bez regularnego przeglądu wszystkich leków, ich interakcji i łącznego obciążenia działaniami niepożądanymi.
- Farmakoterapia powinna uzupełniać odpowiednie dostosowania środowiska, psychoedukację i interwencje psychospołeczne, a nie zastępować ich.

Decyzje o lekach muszą być podejmowane wspólnie z osobą autystyczną, a w razie potrzeby z opiekunem, po omówieniu oczekiwanej korzyści, niepewności dowodów, możliwych działań niepożądanych i alternatyw. Powyższy opis ma charakter edukacyjny i nie zastępuje indywidualnej konsultacji lekarskiej.

Mity i mniej oczywiste błędy w kontakcie z osobami autystycznymi

Klasyczne mity

Mit: szczepienia wywołują autyzm. Duże badania kohortowe i metaanalizy nie wykazują związku przyczynowego między szczepieniami, w tym MMR, a ASD. Wycofana publikacja, od której rozpoczął się ten mit, była obciążona poważnymi błędami i konfliktem interesów. Rezygnacja ze szczepień zwiększa ryzyko chorób zakaźnych, nie zapobiegając autyzmowi.

Mit: autyzm jest skutkiem „zimnego” rodzicielstwa. ASD jest stanem neurorozwojowym o silnym podłożu genetycznym. Styl wychowania nie powoduje autyzmu. Rodzina może natomiast wpływać na dobrostan, podobnie jak u każdej osoby, przez dostęp do bezpieczeństwa, komunikacji, akceptacji i odpowiedniego wsparcia.

Mit: osoba autystyczna nie ma emocji ani empatii. Osoby autystyczne doświadczają pełnego zakresu emocji. Trudność może dotyczyć szybkiego rozpoznania stanu drugiej osoby, nazwania własnych emocji, odczytania niejawnego sygnału lub pokazania troski w formie oczekiwanej przez otoczenie. Podwójny problem empatii wskazuje, że nieporozumienia są dwustronne.

Mit: każda osoba autystyczna ma wybitny talent. Savantyzm jest rzadki. Część osób ma szczególne zdolności, inne przeciętny profil, a część niepełnosprawność intelektualną. Oczekiwanie „ukrytego geniuszu” może prowadzić do ignorowania zwykłych potrzeb i oceniania wartości człowieka przez produktywność.

Mit: dieta, suplementy, chelatacja lub tlen hiperbaryczny leczą ASD. Nie ma wiarygodnych dowodów, że te metody usuwają rdzeniowe cechy ASD. Dietę modyfikuje się przy alergii, celiakii, niedoborze lub problemie gastroenterologicznym, nie jako uniwersalną terapię autyzmu. Chelatacja może być niebezpieczna.

Mit: autyzm dotyczy tylko dzieci. ASD trwa przez całe życie, choć sposób ujawniania cech i potrzeb zmienia się. Dorosły może nauczyć się kompensacji, ale nadal ponosić wysoki koszt sensoryczny, wykonawczy i społeczny.

Mit: wzrost diagnoz dowodzi naglej „epidemii”. Wzrost identyfikacji wynika z wielu nakładających się zjawisk: zmian kryteriów, świadomości, dostępu do usług, diagnozowania osób bez niepełnosprawności intelektualnej oraz lepszego rozpoznawania w grupach wcześniej pomijanych. Dane nadzoru nie rozstrzygają samodzielnie, jaka część trendu ma źródło biologiczne.

Mniej oczywiste błędy interpretacyjne

Błąd: utożsamianie kontaktu wzrokowego z uwagą, szczerością lub szacunkiem. Kontakt wzrokowy może utrudniać słuchanie i zwiększać przeciążenie. Lepszą miarą rozumienia jest treść odpowiedzi, wykonanie zadania lub uzgodniony sposób potwierdzenia.

Błąd: uznawanie płynnej mowy i wysokiego IQ za dowód braku niepełnosprawności. Język i inteligencja nie mierzą funkcjonowania adaptacyjnego, sensoryki, inicjowania działania ani kosztu maskowania. Wsparcie powinno wynikać z profilu potrzeb, a nie z wrażenia podczas krótkiej rozmowy.

Błąd: założenie, że skoro osoba wykonała zadanie raz, może wykonywać je stale bez dostosowań. Możliwość wykonania zadania nie informuje o koszcie, czasie regeneracji i trwałości wysiłku. Dostosowanie może być właśnie przyczyną sukcesu, a nie dowodem, że przestało być potrzebne.

Błąd: interpretowanie potrzeby samotności jako odrzucenia partnera. Wycofanie po pracy, spotkaniu lub konflikcie często służy obniżeniu pobudzenia. W związku warto ustalić czas regeneracji i jasny sygnał powrotu do rozmowy, zamiast wymagać natychmiastowej bliskości.

Błąd: uznawanie meltdownu lub shutdownu za manipulację. Są to reakcje przeciążonego układu regulacji. Odpowiedzią powinno być bezpieczeństwo, ograniczenie bodźców i późniejsza analiza wyzwalaczy, a nie kara, zawstydzanie lub wymuszanie wyjaśnień w trakcie kryzysu.

Błąd: ocenianie braku widocznej mimiki jako braku uczuć. Ekspresja zewnętrzna może być słabsza, opóźniona lub odmienna od intensywności przeżycia. Należy pytać wprost i akceptować odpowiedź tekstową, skalę lub odroczenie rozmowy.

Błąd: przerywanie każdego stimmingu. Kołysanie, ruchy dłoni, chodzenie lub manipulowanie przedmiotem mogą regulować pobudzenie i uwagę. Ograniczenie jest zasadne, gdy zachowanie jest niebezpieczne lub uniemożliwia ważną aktywność; wtedy poszukuje się bezpieczniejszego odpowiednika.

Błąd: wymaganie natychmiastowej odpowiedzi. Osoba może potrzebować czasu na przełączenie uwagi, rozpoznanie emocji i sformułowanie komunikatu. Presja zwiększa ryzyko automatycznego „tak”, wycofania albo eskalacji. Uzgodniony termin odpowiedzi jest skuteczniejszy.

Błąd: trenowanie wyłącznie osoby autystycznej, aby dopasowała się do otoczenia. Interwencja jednostronna utrwala założenie, że problem leży wyłącznie w niej. Równolegle należy zmieniać sposób komunikacji partnera, rodziny, szkoły, pracodawcy i specjaliści oraz usuwać bariery sensoryczne.

Błąd: rozmawianie z opiekunem zamiast z dorosłą osobą autystyczną. Nawet przy dużych potrzebach wsparcia należy zwracać się bezpośrednio do osoby, zapewnić jej kanał komunikacji i pytać o zgodę na udział innych. Opiekun dostarcza informacji, ale nie powinien automatycznie przejmować głosu.

Błąd: traktowanie AAC jako ostateczności lub przeszkody dla mowy. Wspomaganie komunikacji można wdrażać wcześniej i równolegle z rozwojem mowy. Odkładanie AAC pozbawia osobę możliwości wyrażania potrzeb i może nasilać zachowania wynikające z frustracji.

Błąd: uznawanie późnej diagnozy za dowód małego nasilenia. Późna identyfikacja może wynikać z maskowania, nietypowego profilu, wcześniejszej struktury środowiska lub błędnych rozpoznań. Potrzeby trzeba ocenić aktualnie, nie na podstawie wieku diagnozy.

Błąd: przypisywanie każdej nowej trudności autyzmowi. To przesłonięcie diagnostyczne. Nagła zmiana snu, apetytu, zachowania, mowy lub samoobsługi wymaga oceny bólu, choroby somatycznej, przemocy, depresji, padaczki lub działania leków.

Błąd: uznawanie bezpośredniości za celową niegrzeczność. Komunikat może być dosłowny i skoncentrowany na informacji, bez intencji obrażenia. Jednocześnie ASD nie zwalnia z odpowiedzialności za krzywdzące zachowanie; skuteczne jest jasne wyjaśnienie skutku i oczekiwanej alternatywy, a nie domyślne przypisywanie złej woli.

Błąd: wygaszanie intensywnych zainteresowań. Zainteresowania mogą dostarczać wiedzy, relacji, regulacji i ścieżki zawodowej. Ograniczenia są potrzebne dopiero wtedy, gdy aktywność staje się niebezpieczna, całkowicie wypiera podstawowe potrzeby lub narusza prawa innych.

Błąd: używanie diagnozy jako pełnego wyjaśnienia osobowości. Osoba autystyczna ma własny temperament, historię, kulturę, płeć, wartości i doświadczenia. Nie każde zachowanie wynika z ASD, a dwie osoby z tym samym rozpoznaniem mogą wymagać przeciwnych dostosowań.

Błąd: zakładanie, że akceptacja oznacza rezygnację z terapii lub wymagań. Akceptacja oznacza poszanowanie neuroróżnorodności i autonomii. Można jednocześnie leczyć depresję, uczyć komunikacji, rozwijać samodzielność i stawiać granice, o ile cele służą osobie, są proporcjonalne i nie polegają na ukrywaniu nieszkodliwych cech.

Wnioski i priorytety wsparcia

- ASD wymaga oceny indywidualnego profilu, a nie wnioskowania z etykiety, płci, wieku diagnozy, języka lub IQ.
- Najpierw należy zapewnić dostęp do komunikacji, bezpieczeństwo i dostosowanie środowiska; dopiero potem oceniać zachowanie i skuteczność interwencji.
- Problemy współwystępujące, takie jak lęk, depresja, ADHD, padaczka, bezsenność lub ból, wymagają osobnej diagnostyki i leczenia. Autyzm nie może przesłaniać nowych objawów.
- Psychoterapia i farmakoterapia powinny mieć konkretny cel, mierzalny efekt, plan monitorowania i zgodę osoby. Nie służą usuwaniu ASD ani wymuszaniu społecznej normalizacji.
- W relacjach, edukacji i pracy odpowiedzialność za porozumienie jest dzielona. Jasna komunikacja, przewidywalność, adaptacje sensoryczne i czas na przetwarzanie zwykle są skuteczniejsze niż presja na maskowanie.
- Miarą powodzenia nie jest wyłącznie liczba zachowań uznanych za typowe. Należy oceniać jakość życia, autonomię, możliwość wyrażania zgody i odmowy, stabilność funkcjonowania, zdrowie, relacje i subiektywny koszt działania.
- Projektowanie usług powinno odbywać się z realnym udziałem osób autystycznych o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych i poziomach wsparcia.

Uwagi metodologiczne do interpretacji danych

Wskaźniki epidemiologiczne zależą od wieku, roku, obszaru, definicji przypadku, źródła danych i dostępu do diagnozy. Wartość CDC 1 na 31 dotyczy dzieci ośmioletnich w 16 obszarach USA w 2022 r., a nie całego świata ani wszystkich grup wieku. Dane polskie pochodzą z regionalnych rejestrów z lat 2010–2014 i nie opisują aktualnej częstości krajowej.

W metaanalizach duża heterogeniczność oznacza, że średnia może słabo opisywać konkretną populację. Dotyczy to zwłaszcza samobójczości, współchorobowości, zatrudnienia i skuteczności interwencji. Badania często nadreprezentują dzieci, chłopców, osoby mówiące i osoby bez dużej niepełnosprawności intelektualnej; wnioski dla kobiet, dorosłych, osób starszych, niemówiących i osób o wysokich potrzebach wsparcia są mniej pewne.

Skuteczność interwencji powinna być oceniana w obszarze, który rzeczywiście był mierzony. Poprawa wyniku kwestionariusza, liczby słów lub zachowania w gabinecie nie musi oznaczać generalizacji do domu, szkoły, relacji ani jakości życia. Konieczne jest rozróżnianie efektu statystycznego od klinicznie ważnej zmiany oraz uwzględnienie działań niepożądanych, kosztu, obciążenia rodziny i perspektywy osoby autystycznej.

W raporcie używa się zarówno określenia „osoba z ASD”, jak i „osoba autystyczna”. Preferencje językowe są indywidualne; w praktyce należy pytać osobę, jak chce być określana. Terminologia neuroafirmatywna nie neguje niepełnosprawności ani potrzeby leczenia, lecz sprzeciwia się ocenianiu cech wyłącznie przez zgodność z normą neurotypową.

Raport ma charakter edukacyjny i nie zastępuje indywidualnej diagnozy ani decyzji lekarza, psychologa, logopedy lub zespołu wielospecjalistycznego. Statystyki populacyjne nie służą do przewidywania przebiegu u pojedynczej osoby.

Bibliografia

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR).
- Asperger, H. (1944). Die „Autistischen Psychopathen” im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117, 76–136.
- Aydin, O., Sulu, M. D., & Ari-Arat, C. (2025). A meta-analysis of self-management interventions in teaching daily living skills to autistic individuals. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 55, 2377–2392. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06355-w>
- Bai, D., Yip, B. H. K., Windham, G. C., et al. (2019). Association of genetic and environmental factors with autism in a 5-country cohort. *JAMA Psychiatry*, 76(10), 1035–1043. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.1411>
- Botha, M., Dibb, B., & Frost, D. M. (2022). “Autism is me”: An investigation of how autistic individuals make sense of autism and stigma. *Disability & Society*, 37(3), 427–453. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1822782>
- Brede, J., Cage, E., Trott, J., Palmer, L., Smith, A., Serpell, L., Mandy, W., & Russell, A. (2022). “We have to try to find a way, a clinical bridge”: Autistic adults’ experience of accessing and receiving support for mental health difficulties: A systematic review and thematic meta-synthesis. *Clinical Psychology Review*, 93, 102131. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102131>
- Buckland, R. (2024). *The Buckland Review of Autism Employment: Report and Recommendations*. UK Government.
- Cai, R. Y., Edwards, C., Love, A. M. A., Brown, L., & Gibbs, V. (2024). Self-compassion improves emotion regulation and mental health outcomes: A pilot study of an online self-compassion program for autistic adults. *Autism*, 28(10). <https://doi.org/10.1177/13623613241235061>
- Cai, R. Y., Love, A., Robinson, A., & Gibbs, V. (2023). The inter-relationship of emotion regulation, self-compassion, and mental health in autistic adults. *Autism in Adulthood*, 5, 335–342. <https://doi.org/10.1089/aut.2022.0068>
- Camm-Crosbie, L., Bradley, L., Shaw, R., Baron-Cohen, S., & Cassidy, S. (2019). “People like me don’t get support”: Autistic adults’ experiences of support and treatment for mental he-

- alth difficulties, self-injury and suicidality. *Autism*, 23(6), 1431–1441. <https://doi.org/10.1177/1362361318816053>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2025). Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years—ADDN Network, 16 Sites, United States, 2022. *MMWR Surveillance Summaries*, 74(2).
- Cook, J., Hull, L., Crane, L., & Mandy, W. (2021). Camouflaging in autism: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 89, 102080. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102080>
- Cope, R., & Remington, A. (2022). The strengths and abilities of autistic people in the workplace. *Autism in Adulthood*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.1089/aut.2021.0037>
- Crompton, C. J., Ropar, D., Evans-Williams, C. V. M., Flynn, E. G., & Fletcher-Watson, S. (2020). Autistic peer-to-peer information transfer is highly effective. *Autism*, 24(7), 1704–1712. <https://doi.org/10.1177/1362361320919286>
- Fieiras, C., et al. (2023). Risperidone and aripiprazole for autism spectrum disorder in children: An overview of systematic reviews. *BMJ Evidence-Based Medicine*.
- Grace, K., Remington, A., Lloyd-Evans, B., Davies, J., & Crane, L. (2022). Loneliness in autistic adults: A systematic review. *Autism*, 26(8), 2117–2135. <https://doi.org/10.1177/13623613221077721>
- Grove, J., Ripke, S., Als, T. D., et al. (2019). Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder. *Nature Genetics*, 51, 431–444.
- Howes, O. D., et al. (2018). Autism spectrum disorder: Consensus guidelines on assessment, treatment and research from the British Association for Psychopharmacology. *Journal of Psychopharmacology*, 32(1), 3–29.
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 2, 217–250.
- Khaw, J., & Vernon, T. (2025). Relationship satisfaction among autistic populations: How partner neurotype influences relationship satisfaction factors for autistic and non-autistic partners. *Journal of Autism and Developmental Disorders*.
- Lai, M.-C., Kasse, C., Besney, R., et al. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 6(10), 819–829.
- Linden, A., et al. (2023). Psychotherapy for co-occurring symptoms of depression, anxiety and obsessive-compulsive disorder in children and adults with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis.
- Lockwood Estrin, G., Milner, V., Spain, D., Happé, F., & Colvert, E. (2021). Barriers to autism spectrum disorder diagnosis for young women and girls: A systematic review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 8, 454–470.
- Mason, D., Ingham, B., Urbanowicz, A., Michael, C., Birtles, H., Woodbury-Smith, M., Brown, T., James, I., Scarlett, C., Nicolaidis, C., & Parr, J. R. (2019). A systematic review of what barriers and facilitators prevent and enable physical healthcare services access for autistic adults. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49, 3387–3400. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04049-2>
- Maïano, C., Normand, C. L., Salvas, M.-C., Moullec, G., & Aimé, A. (2016). Prevalence of school bullying among youth with autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. *Autism Research*, 9(6), 601–615.
- Milton, D. E. M. (2012). On the ontological status of autism: The “double empathy problem”. *Disability & Society*, 27(6), 883–887.

- National Institute for Health and Care Excellence. (2021). Autism spectrum disorder in adults: Diagnosis and management (CG142).
- National Institute for Health and Care Excellence. (2021, surveillance updated). Autism spectrum disorder in under 19s: Support and management (CG170).
- Newell, V., Phillips, L., Jones, C., Townsend, E., & Richards, C. (2023). A systematic review and meta-analysis of suicidality in autistic and possibly autistic people without co-occurring intellectual disability. *Molecular Autism*, 14, 12. <https://doi.org/10.1186/s13229-023-00544-7>
- Perihan, C., et al. (2020). Effects of cognitive behavioral therapy for reducing anxiety in children with high-functioning autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50, 1958–1972.
- Pope, L., Light, J., & Laubscher, E. (2025). The effect of naturalistic developmental behavioral interventions and aided AAC on the language development of children on the autism spectrum with minimal speech: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 55, 3078–3099. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06382-7>
- Raymaker, D. M., Teo, A. R., Steckler, N. A., et al. (2020). “Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew”: Defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143.
- Salari, N., Rasoulpoor, S., Rasoulpoor, S., et al. (2022). The global prevalence of autism spectrum disorder: A comprehensive systematic review and meta-analysis. *Italian Journal of Pediatrics*, 48, 112.
- Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley LaPoint, S., et al. (2023). Autism intervention meta-analysis of early childhood studies (Project AIM): Updated systematic review and secondary analysis. *BMJ*, 383, e076733. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076733>
- Sasson, N. J., Faso, D. J., Nugent, J., Lovell, S., Kennedy, D. P., & Grossman, R. B. (2017). Neurotypical peers are less willing to interact with those with autism based on thin slice judgments. *Scientific Reports*, 7, 40700.
- Satterstrom, F. K., Kosmicki, J. A., Wang, J., et al. (2020). Large-scale exome sequencing study implicates both developmental and functional changes in the neurobiology of autism. *Cell*, 180(3), 568–584.e23.
- Skonieczna-Żydecka, K., Gorzkowska, I., Pierzak-Sominka, J., & Adler, G. (2017). The prevalence of autism spectrum disorders in West Pomeranian and Pomeranian regions of Poland. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30(2), 283–289.
- Strunz, S., Schermuck, C., Ballerstein, S., Ahlers, C. J., Dziobek, I., & Roepke, S. (2017). Romantic relationships and relationship satisfaction among adults with Asperger syndrome and high-functioning autism. *Journal of Clinical Psychology*, 73(1), 113–125.
- Tubío-Fungueiriño, M., Cruz, S., Sampaio, A., Carracedo, A., & Fernández-Prieto, M. (2021). Social camouflaging in females with autism spectrum disorder: A systematic review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51, 2190–2199.
- van Rooij, D., Anagnostou, E., Arango, C., et al. (2018). Cortical and subcortical brain morphometry differences between patients with autism spectrum disorder and healthy individuals across the lifespan: Results from the ENIGMA ASD Working Group. *American Journal of Psychiatry*, 175(4), 359–369.
- Weston, L., Hodgekins, J., & Langdon, P. E. (2016). Effectiveness of cognitive behavioural therapy with people who have autistic spectrum disorders: A systematic review and meta-

analysis. *Clinical Psychology Review*, 49, 41–54.

Wing, L., & Gould, J. (1979). Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 9, 11–29.

World Health Organization. (2022). *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*.

World Health Organization. (2025). *Autism. Fact sheet*.

Yew, R. Y., Hooley, M., & Stokes, M. A. (2023). Factors of relationship satisfaction for autistic and non-autistic partners in long-term relationships. *Autism*, 27(8), 2348–2360. <https://doi.org/10.1177/13623613231160244>